การบริการทางการแพทย์
ระดับกองพล

โดย
พ.อ.ประจวบ วันตา
อจ.หน.รร.สร.พบ.

ขอบเขตการสอน/ เอกสารอ้างอิง

กองทัพบก

คู่มือราชการสนาม

ว่าด้วย

หลักนิยมการบริการทางการแพทย์

พ.ศ. ๒๕๖๒

บทที่ 2 การบริการแพทย์เขตยุทธบริเวณ

3. กองพันเสนารักษ์และการบริการแพทย์ระดับกองพล

คู่มือราชการสนาม

ว่าด้วย

หลักนิยม ว่าด้วยการบริการทางการแพทย์

พ.ศ.2562

คลังตำรา
รร.สร.พบ.

การบริการทางการแพทย์
ระดับหน่วย

การบริการทางการแพทย์
ในสนาม(สงคราม)

เขตสงคราม

เขตภายใน

5. การบริการทางการแพทย์ระดับเขตภายใน

รพ.ทบ. (นขต.พบ.)
- รพ.รร.6
- รพ.อ.ป.ร.
- รพ.ค่ายสุรนารี
- รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ทร.
- รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ทอ.
- รพ.องค์การทหารผ่านศึก
- รพ.พลเรือนที่กำหนด

เฉพาะทาง พักฟื้น อวัยวะเทียม

เขตยุทธบริเวณ

เขตหลัง

4. การบริการทางการแพทย์ระดับเขตหลัง

รพ.มทบ./รพ.พลเรือนในพื้นที่

เฉพาะทาง

เขตหน้า

1. การบริการทางการแพทย์ระดับหน่วย
ขนาดหน่วยตั้งแต่ มว.สร. ลงมา
ฉุกเฉิน TCCC

2. การบริการทางการแพทย์ระดับกองพล
พัน.สร.พล ช่วยชีวิตขั้นแรก

3. การบริการทางการแพทย์ระดับกองทัพภาค
พัน.สร.บชร. รักษาช่วยชีวิต

การบริการทางการแพทย์ทางยุทธวิธี

การบริการทางการแพทย์ ระดับหน่วย

การบริการทางการแพทย์ ในสนาม(สงคราม)

ลำดับการรักษาพยาบาลและการส่งกลับในสนาม ทบ.

4-5

เขตหลัง/ภายใน

ที่เฉพาะ/พักฟื้น

18 คัน

มว.รยพ.

30 วัน

พัน.สร.บชร.

ช่วยชีวิต

ร้อย.สร.สน.

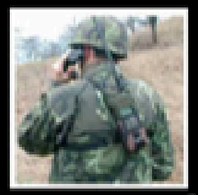
ชุดศัลยกรรมสนาม

ชุดรักษาพยาบาล

3.ระดับ ทภ.

เร่งด่วน

มว.สร.



ร้อย.สสช.พัน.ร.

ตอนส่งกลับ

3 คัน

10 คัน

20 วัน

ร้อย.สร.

ช่วยชีวิตขั้นแรก

พัน.สร.

กรม สน.พล.ร.

2.ระดับกองพล

ลาก/ อุ้ม/ เปล

1.ระดับหน่วย

TCCC พบ.

ช่วยเหลือตนเอง

SELF AID

ช่วยเหลือโดยเพื่อน

BUDDY AID

ส.พยาบาลกองร้อย

AID MAN

การบริการทางการแพทย์ ระดับกองพล

ความหมาย

การบริการทางการแพทย์ระดับกองพล

1. - การอำนวยการ หรือ การดำเนินการบริการแพทย์ของหน่วยทหารระดับกองพล
   - ให้การบริการแพทย์อื่น ๆ ต่อหน่วยแพทย์ในพื้นที่ของกองพล เช่น
     - การส่งกำลัง สป.2,4 สายแพทย์
     - การ ซบร. ยุทธภัณฑ์สายแพทย์ขั้นหน่วย
2. - เป็นการให้การรักษาพยาบาลเพิ่มเติม ต่อจากการได้รับการบริการในระดับหน่วย มาแล้ว

ประเภทหน่วย พล.ร.ทบ.ไทย

10 พล.ร.

ตอนที่ ๑ : กล่าวทั่วไป

ตอนที่ ๒ : กองพลทหารราบ

พล.ร. (มาตรฐาน)

พล.1 รอ., พล.ร.3, 4, 5, 6 และ 11

ในตอนนี้จะกล่าวถึงกองพลทหารราบมาตรฐานทั่วๆ ไปซึ่งมีรูปแบบการจัดตามที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน เช่น กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์, กองพลทหารราบที่ ๓, ๔, ๕, ๖,๑๑ เป็นต้น คำย่อที่ใช้ในเอกสารเล่มนี้จะใช้คำว่า "พล.ร."

ตอนที่ ๓ : กองพลทหารราบยานเกราะ

พล.ร..ยก.

พล.ร.2 รอ.

เป็นรูปแบบการจัดกองพลทหารราบ เพื่อให้มีความทันสมัยพร้อมที่จะรับสถานการณ์ได้ทุกรูปแบบ สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็ว ปฏิบัติการรุกได้อย่างทันที สอดคล้องกับรูปแบบของสงครามในอนาคต รวมทั้งสงครามนิวเคลียร์ ชีวะ เคมีด้วย ปัจจุบันหน่วยที่มีรูปแบบการจัดคือ พล.ร.๒ รอ. คำย่อที่ใช้ในเอกสารเล่มนี้จะใช้คำว่า "พล.ร.ยก."

ตอนที่ ๔ : กองพลทหารราบยานยนต์

เป็นรูปแบบการจัดกองพลทหารราบในอนาคต มุ่งหมายที่จะจัดให้เป็น พล.ร.มาตรฐาน ที่มีขีดความสามารถในการ เข้าตี ตั้งรับ และร่นถอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ คำย่อที่ใช้ในเอกสารเล่มนี้จะใช้คำว่า "พล.ร.ยย."

ตอนที่ ๕ : กองพลทหารราบเบา

พล.ร. เบา

พล.ร.7, 9 และ 15

เป็นรูปแบบการจัดกองพลทหารราบ โดยมีความมุ่งหมายที่จะใช้ตอบสนอง ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติในด้านการรักษาความมั่นคงภายใน การป้องกันประเทศ และภารกิจอื่นๆ ตามความเหมาะสม ปัจจุบันหน่วยที่มีการจัดรูปแบบนี้ ได้แก่ พล.ร.๗,๙และ ๑๕ คำย่อที่ใช้ในเอกสารเล่มนี้ จะใช้คำว่า "พล.ร.เบา"

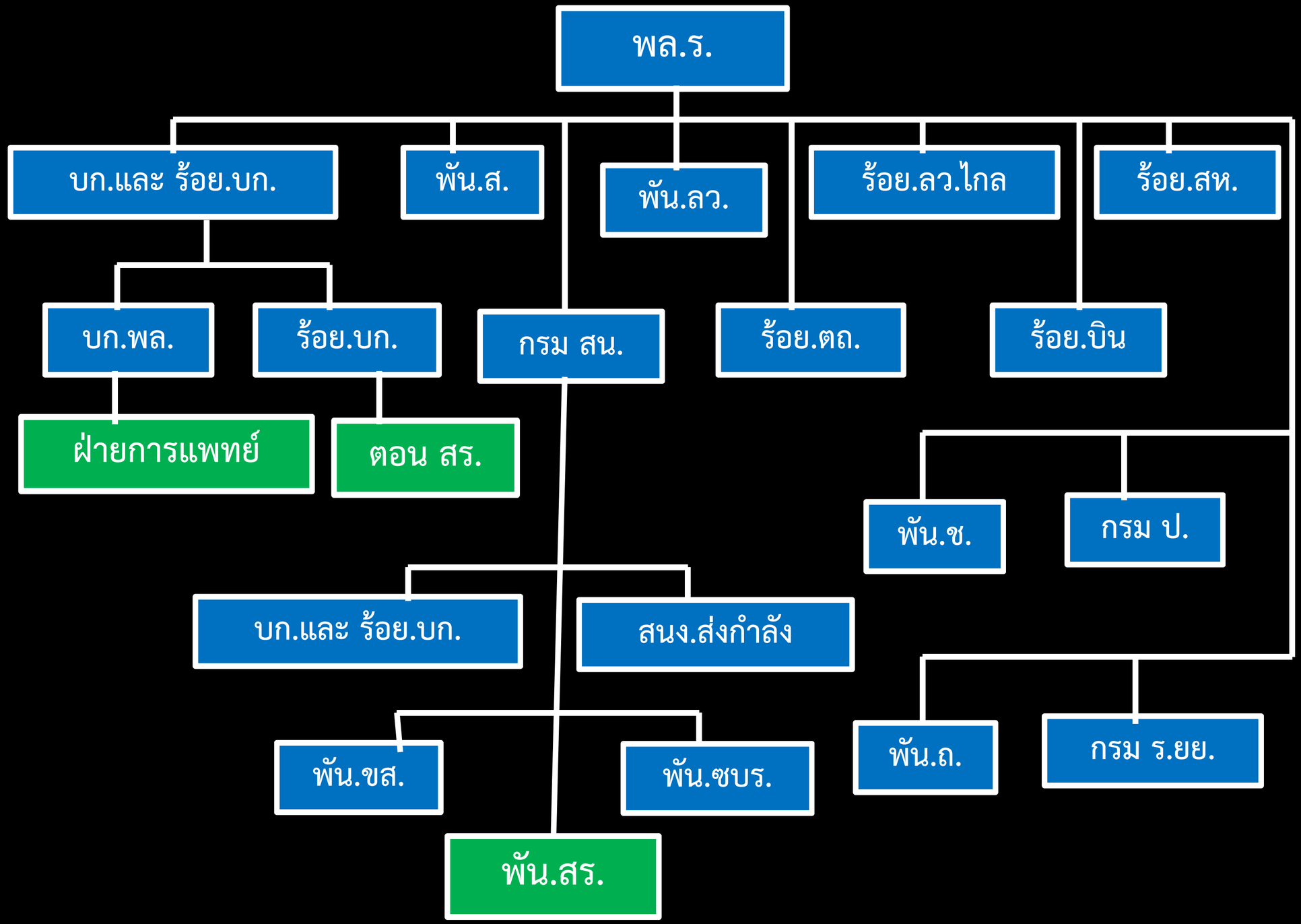
รายละเอียดการจัด ภารกิจ ขีดความสามารถ ข้อจำกัดสะแกนเลย

การบริการทางการแพทย์

ระดับกองพล

หน่วยสายแพทย์ใน พล.ร.

- ฝ่ายการแพทย์ กองพล
- ตอน สร. ร้อย.บก.พล.ร.
- พัน.สร.พล.ร.


พล.ร.
บก.และ ร้อย.บก.
พัน.ส.
พัน.ลว.
ร้อย.ลว.ไกล
ร้อย.สห.
บก.พล.
ร้อย.บก.
กรม สน.
ร้อย.ตถ.
ร้อย.บิน
ฝ่ายการแพทย์
ตอน สร.
พัน.ช.
กรม ป.
บก.และ ร้อย.บก.
สนง.ส่งกำลัง
พัน.ขส.
พัน.ซบร.
พัน.ถ.
กรม ร.ยย.
พัน.สร.

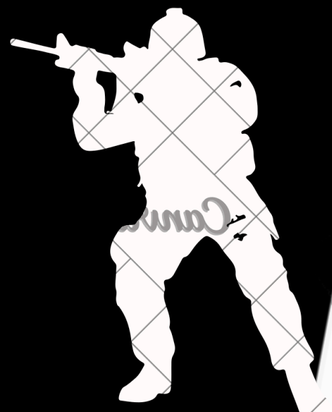
การบริการทางการแพทย์
ระดับกองพล

หน่วยสายแพทย์ใน พล.ร.

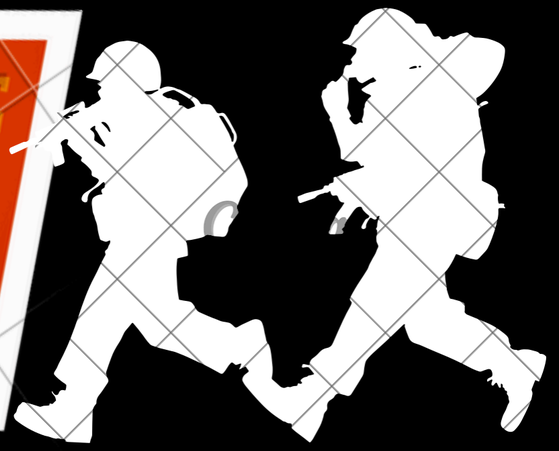
หน่วยที่ให้การบริการแพทย์ระดับกองพล

(หน่วยปฏิบัติ)

คือ



พัน.สร.พล.ร./ม.



ฝ่ายการแพทย์กองพล

กำลังพลที่บรรจุ

- เป็น ฝก.(สายแพทย์) ของ ผบ.พล.

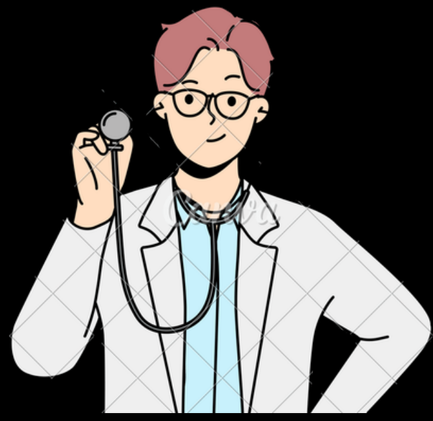
พญ.พล.	พ.ท.	ชกท.3000	1
* นพ.	พ.ต.	ชกท.3100	1
เสมียน	จ.	ชกท.710	1
เสมียนพิมพ์	ส.อ.	ชกท.711	-
	รวม		3

* ทำหน้าที่ ผบ.ตอน.สร.ฯ ด้วย

ฝ่ายการแพทย์กองพล

ที่ตั้ง

- ในที่ตั้งปกติ จัดตั้งใน บก.พล.
- ในสนาม ปฏิบัติงานที่ ทก.พล.(หลัง)



ทำอะไรบ้าง

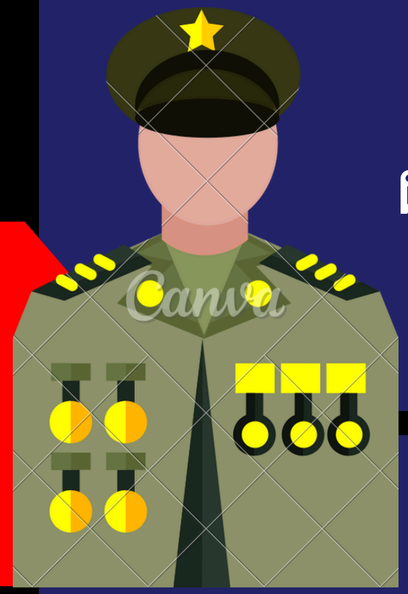
- เป็นฝ่ายกิจการพิเศษ(สายแพทย์)
- ตรวจเยี่ยม นขต.พล./หน่วยขึ้นสมทบ/หน่วยสนับสนุน
- นพ.พล. ปฏิบัติหน้าที่แทนเมื่อ พญ.พล.ไม่อยู่

การบริการทางการแพทย์
ระดับกองพล

ฝ่ายการแพทย์ พล.ร.

พญ.พล.ร.

มีหน้าที่



- ให้ข่าวสาร ข้อมูลทางการแพทย์ ช่วยเหลือ ผบ.พล. ในการบังคับบัญชาควบคุมหน่วยแพทย์ในอัตราของ พล.ร.

- รายงานสถานการณ์ทางการแพทย์ใน พล.ร. ให้ พญ.ทภ. ทราบ

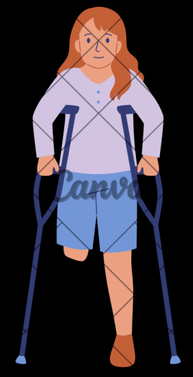
การบริการทางการแพทย์
ระดับกองพล

ฝ่ายการแพทย์ พล.ร.

หน้าที่ของ พญ.พล.

- จัดทำแผน/รปจ. ทางการแพทย์
  ภายใต้การกำกับดูแลของ สธ.4 ให้ครอบคลุมในเรื่อง

1. มาตรการป้องกัน ลดความพิการ และการสูญเสีย
2. มาตรการป้องกัน รักษาโรค แก่ เชลยศึก พลเรือน ในพื้นที่ยึดครอง
3. ฝึกอบรม จัดทำหลักสูตรต่าง ๆ
4. การส่งกำลัง สป.2,4 สายแพทย์
5. รายงานสถานภาพผู้ป่วยเจ็บ
6. ตรวจเยี่ยมทางฝ่ายอำนวยการ
7. ประสานการส่งกลับผู้ป่วยเจ็บ



การบริการทางการแพทย์
ระดับกองพล

หน่วยสายแพทย์ใน พล.ร.

ตอน สร.ร้อย.บก.พล.

- เป็นการบริการแพทย์ระดับหน่วย
- ให้การรักษาพยาบาลขั้นต้น แก่เจ้าหน้าที่ ใน บก.พล. และ นขต.บก.พล.
- เปิดที่ตรวจโรคใกล้ ๆ กับ ทก.พล.(หลัง)

สามารถร้องขอการส่งกลับไปยัง ที่พยาบาลกองพล
หรือหน่วยแพทย์ ที่อยู่ข้างหลังอื่น ๆ ถ้า ที่พยาบาลกองพลตั้งล้ำไปข้างหน้ามาก

การบริการทางการแพทย์
ระดับกองพล

หน่วยสายแพทย์ใน พล.ร.

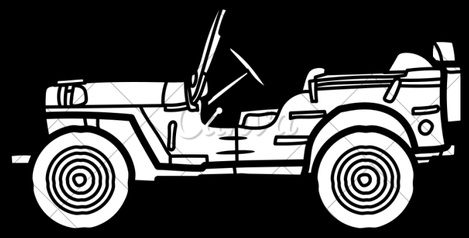
ตอน สร.ร้อย.บก.พล.

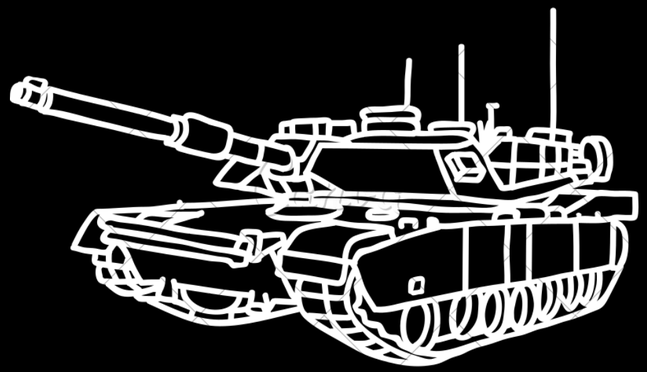
ผบ.ตอน.	- นพ.พล.(พ.ต.) ทำหน้าที่		(1)
น.พยาบาล	ร.อ.	ชกท.3506	1
ส.พยาบาล	จ(พ.)	ชกท.912	1
	จ.	ชกท.912	1
ส.พยบ.กองร้อย	ส.อ.	ชกท.912	5
พลขับ	ส.อ.	ชกท.640	1
พล.สร.	พล.ฯ	ชกท.910	4

รวม 13 นาย

พัน.สร.พล.ร.

ในกองพลอื่น ๆ ก็มีลักษณะ การจัดและภารกิจเช่นเดียวกัน
จะแตกต่างเฉพาะจำนวนกำลังพลและยานยนต์เท่านั้น





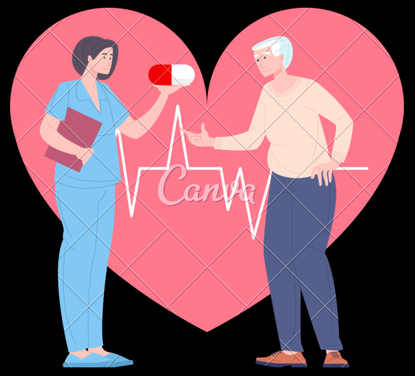
การบริการทางการแพทย์ ระดับกองพล

พัน.สร.พล.ร.

- ให้การบริการแพทย์**ระดับกองพล**

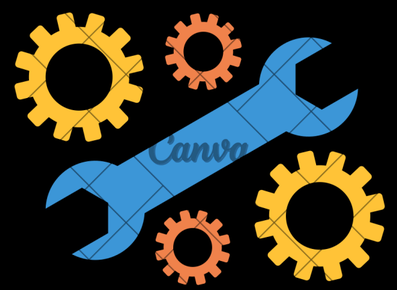
- รับผิดชอบบริการทางการแพทย์ในพื้นที่ กองพลทหารราบ ในพันธกิจทางการแพทย์ 4 ประการ

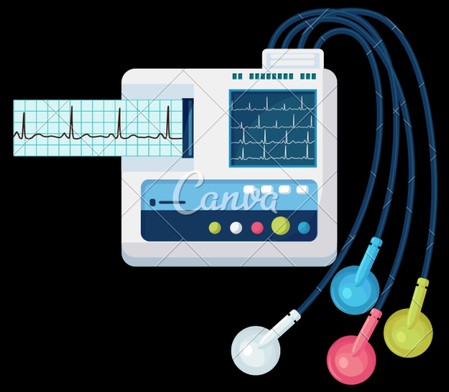
1. การเวชกรรมป้องกัน
2. การรักษาพยาบาลและการส่งกลับ
3. การส่งกำลังสายแพทย์
4. การบริการทางการแพทย์อื่น ๆ



ภารกิจ

ให้การบริการแพทย์ระดับกองพล
แก่หน่วยในพื้นที่ของกองพล โดยการ





- การส่งกลับผู้ป่วยเจ็บ
- การรักษาพยาบาล
- การ ซบร.เครื่องมือ พ.
- การส่งกำลัง สป.2-4 สายแพทย์

ให้แก่หน่วยที่ให้บริการทางการแพทย์ในพื้นที่ของกองพล

การแบ่งมอบ

จัดเป็นหน่วยในอัตราของ พล.ร.

ในอัตรา

1 กองพันเสนารักษ์ ต่อ 1 พล.ร./ม.

*1 กองพันเสนารักษ์ ต่อ 1 กรมสนับสนุน

การบริการทางการแพทย์

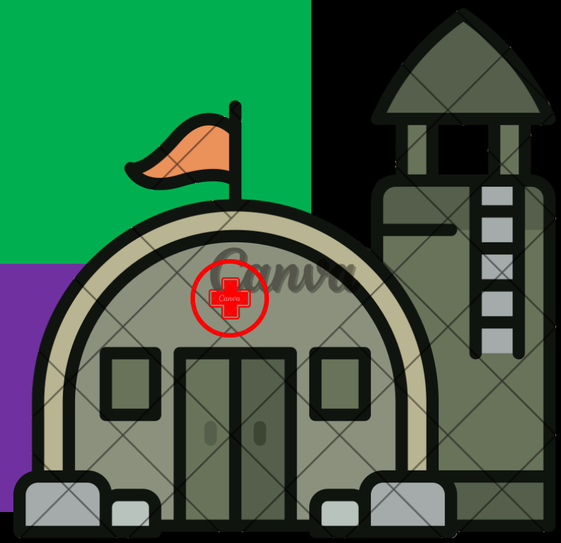
ระดับกองพล

พัน.สร.พล.ร.

ขีดความสามารถ

* จัดตั้ง/ดำเนินการ ที่พยาบาลกองพล 4 แห่ง
  - ที่พยาบาลกองพล 1 แห่ง (ร้อย.สร.สน.)
  - ที่พยาบาลกองพลหน้า 3 แห่ง (ร้อย.สร.)

* รักษาโรคทั้งทางอายุรกรรม ศัลยกรรม ทันตกรรม
* ส่งกำลัง สป.2,4 สาย พ. ให้หน่วยต่าง ๆ ใน กองพล
* ซบร. เวชบริภัณฑ์ขั้นหน่วย (หน่วย ตรง ไป คลัง)



* ส่งกลับ ผป.จาก ที่พยาบาลต่าง ๆ
* เคลื่อนที่ด้วยตนเอง 100 %

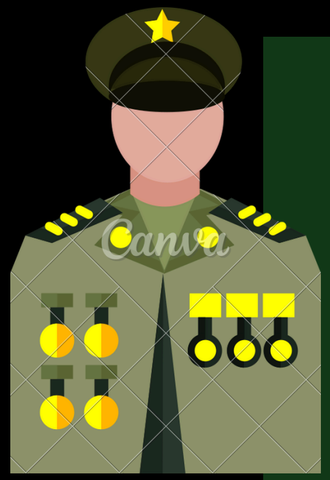
พัน.สร.พล.ร.

การจัด

- พล.ร.
  - พัน.สร.
    - บก.และ ร้อย.บก.
    - ร้อย.สร.สน.
    - ร้อย.สร.

พัน.สร.พล.ร.

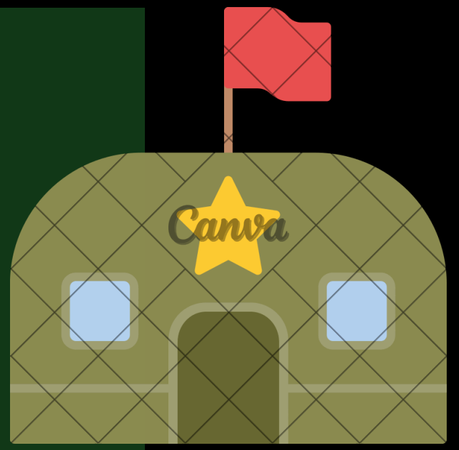
บก.และ ร้อย.บก.



จัดเป็นหน่วยในอัตราของ

พัน.สร.พล.

ในอัตรา 1 กองร้อย ต่อ 1 พัน.สร.พล.



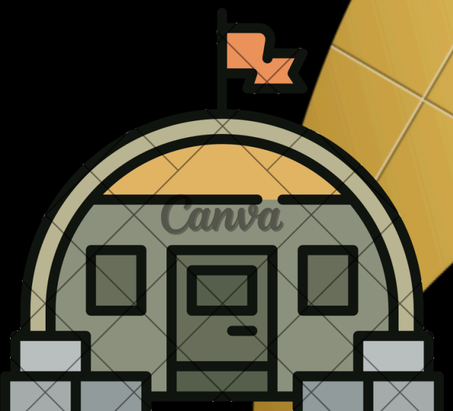
บก.และ ร้อย.บก.

ภารกิจ

- บังคับบัญชา
- วางแผน
- ควบคุม
- กำกับดูแล

การปฏิบัติ การบริการ พ. ในระดับ กองพล ของ

- หน่วยในอัตรา
- หน่วยที่มาสมทบ



บก.และ ร้อย.บก.

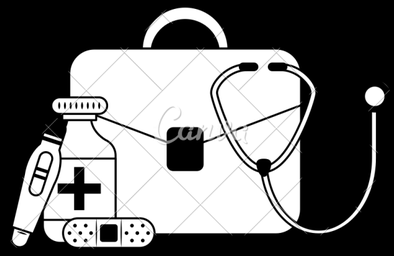
ขีดความสามารถ

* กำกับดูแล ควบคุมการปฏิบัติการบริการแพทย์
* วางแผนกำกับดูแลการฝึกทางเทคนิค และไม่ใช่ทางเทคนิค
* ดำเนินการและสนับสนุนด้าน ธก. /กพ. /สื่อสาร ให้กับ นขต. / หน่วย พ. ที่มาสมทบ

บก.และ ร้อย.บก.

ขีดความสามารถ

* ดำเนินการซ่อมเวชบริภัณฑ์ขั้นหน่วย ให้กับ นขต. / หน่วย พ. ที่มาสมทบ
* ดำเนินการส่งกำลัง สป.สาย พ.ให้กับ นขต. / หน่วย พ. ที่มาสมทบ
* ดำเนินการส่งกำลัง สป.สาย อื่น ๆ ให้กับ นขต. / หน่วย พ. ที่มาสมทบ



การบริการทางการแพทย์

ระดับกองพล

พัน.สร.

กำลังพล บก.และร้อย.บก.

- บก. และ ร้อย บก.
  - 119 (น.11 ส.59 พลฯ 49)
  - บก.พัน. 7
  - ร้อย.บก. 112 (น.4 ส.59 พลฯ 49)
    - บก.ร้อย. 48
    - ตอนส่งกำลัง 13
    - ตอน บก.พัน. 20
    - ตอน ซบร. 18
    - ตอนสื่อสาร 13
- ร้อย.สร.สน.
- ร้อย.สร.

บก.พัน.สร.

ตำแหน่ง	ยศ	เต็ม	ลด2
ผบ.พัน.	พ.ท.	1	1
รอง ผบ.พัน.	พ.ต.	1	1
น.ธุรการ และกำลังพล	ร.อ.	1	1
น.ยุทธการ และการข่าว	พ.ต.	1	1
ผช.น.ยุทธการและการข่าว	ร.อ.	1	-
น.ส่งกำลังบำรุง	ร.อ.	1	1
น.การเงิน	ร.อ.	1	1
รวม		7	6

การบริการทางการแพทย์
ระดับกองพล

ร้อย.บก.พัน.สร.พล.ร.

ตำแหน่ง	ยศ	เต็ม	ลด2
ผบ.ร้อย.	ร.อ.	1	1
รอง ผบ.ร้อย.	ร.ท.	1	-
จ่ากองร้อย	จ.(พ.)	1	1
ส.ช่างอาวุธ	จ.	1	1
ส.สูทกรรม	จ.	1	1
พลสูทกรรม	ส.อ.	3	1
	ส.ต.	4	2
	พลฯ	12	8
เสมียน	ส.อ.	1	-

ตำแหน่ง	ยศ	เต็ม	ลด2
พลขับรถ	จ.	1	-
	ส.อ.	5	-
ทหารบริการ	พลฯ	11	-
พลลูกมือ	จ.	6	-
รวม		48	18

รยบ.1/4 ตัน = 1

รยบ.2 ½ ตัน = 2

รยบ.3/4 ตัน = 1

รถบรรทุกน้ำ 2,000gl = 1

การบริการทางการแพทย์
ระดับกองพล

ตอน บก.พัน.
ร้อย.บก.พัน.สร.พล.ร.

ตำแหน่ง	ยศ	เต็ม	ลด2
จ่ากองพัน	จ.(พ.)	1	1
ส.ธุรการและกำลังพล	จ.	1	1
ส.ยุทธการและการข่าว	จ.(พ.)	1	1
ส.ส่งกำลัง	จ.(พ.)	1	1
	ส.อ.	1	1
เสมียนการเงิน	จ.	1	1
	ส.อ.	2	1
ช่างเขียน	ส.อ.	1	-
เสมียน	ส.อ.	2	1

ตำแหน่ง	ยศ	เต็ม	ลด2
พลขับรถ	ส.อ.	7	5
พลลูกมือ	พลฯ	2	-
รวม		20	13
รยบ.1/4 ตัน = 4		รยบ.2 ½ ตัน = 3	

การบริการทางการแพทย์ ระดับกองพล

ตอน สื่อสาร ร้อย.บก.พัน.สร.พล.ร.

ตำแหน่ง	ยศ	เต็ม	ลด2
ผบ.ตอน	จ.	1	1
หน.พลทางสาย	จ.	1	1
พลทางสาย	ส.อ.	2	1
	พล.ฯ	2	1
หน.พนักงานสลับสาย	จ.	1	1
พนักงานสลับสาย	ส.อ.	2	1
	พลฯ	2	1

ตำแหน่ง	ยศ	เต็ม	ลด2
พนักงานวิทยุ	ส.อ.	1	1
พลนำสาร	ส.อ.	1	1
รวม		13	9
รยบ.3/4 ตัน = 2			

ตอนซ่อมบำรุง
ร้อย.บก.พัน.สร.พล.ร.

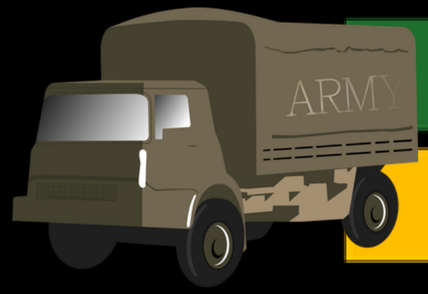
ตำแหน่ง	ยศ	เต็ม	ลด2
น.ยานยนต์	ร.ท.	1	1
ส.ยานยนต์	จ.(พ.)	1	1
ส.ช่างยานยนต์	จ.	1	1
	ส.อ.	4	2
ส.ซ่อมเวชบริภัณฑ์	จ.	1	1
	ส.อ.	1	1
พลขับรถ	ส.อ.	3	1
พลลูกมือ	พลฯ	6	2
รวม		18	10

รยบ.1/4 ตัน = 1

รยบ. 2 1/2 ตัน = 2

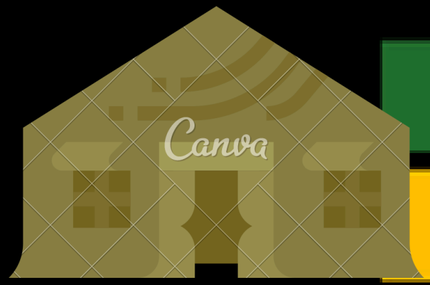
ร้อย.บก.พัน.สร.พล.ร.

สรุปสถานภาพของยานพาหนะ



ขนาด/ประเภท	1/4	3/4	2 1/2	3/4 พยบ.	น้ำ
จำนวน(คัน)	6	3	9	-	1

สรุปสถานภาพของ กระโจม



ขนาด/ประเภท	ทก.	อาหาร	ชบร.	S	M	L
จำนวน(หลัง)	2	1	1	2	2	-

การบริการทางการแพทย์
ระดับกองพล

บก.และร้อย.บก.

ผบ.พัน.สร.

* เป็น ผบ.หน่วย (แพทย์)

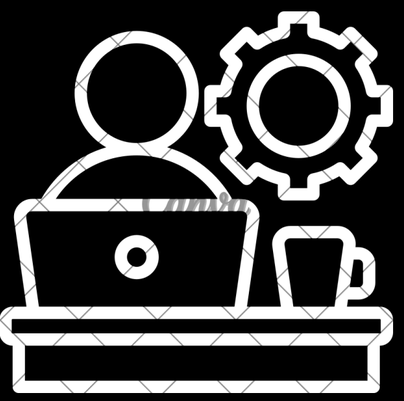
* เป็น ฝก. ของ ผบ.พล.ร. รับผิดชอบแทน ในเรื่อง
- ธุรการ/วินัย/การฝึก ในกองพัน
- วางแผน/อำนวยการ/บริการ พ.ทางยุทธวิธี
- ส่งกลับ ผป.
- จัดตั้ง ที่พยาบาลกองพล
- คัดแยก/ส่งกลับ/ส่งคืน ผป.
- จัดที่พักระหว่างรอการส่งกลับ
- นอกสถานการณ์รบเปิดที่ตรวจโรค รักษาโรคให้กำลังพล
- ดำเนินการ/วางมาตรการ/ตรวจสอบ การส่งกำลังในหน่วย(สาย พ./ทั่วไป) เพียงพอหรือไหม่

รอง ผบ.พัน.สร.

* เป็น นายทหารพยาบาล
* เป็น ผช.หลักของ ผบ.พัน.สร.
* ทำหน้าที่ หน.ฝอ.
* ถ่ายทอดคำสั่งให้ ฝอ./ติดตามสถานการณ์
* กำหนดการทำแผนในอนาคต
* ทำการแทน /พร้อมทำหน้าที่ ผบ.พัน.สร.

นายทหารธุรการและกำลังพล

ให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยเหลือ ผบ.พัน.สร. ในความรับผิดชอบ เรื่อง



ให้คำปรึกษา/แนะนำ/ช่วยเหลือ ผบ.พัน. เกี่ยวกับ

* งานธุรการ
* การรักษายอดกำลังพล
* การจัดการกำลังพล
* การพัฒนารักษาขวัญ
* การรักษาวินัย กฎ คำสั่ง ข้อบังคับ
* การจัดใน บก.
* งานเบ็ดเตล็ด
* งานมอบหมาย

การบริการทางการแพทย์

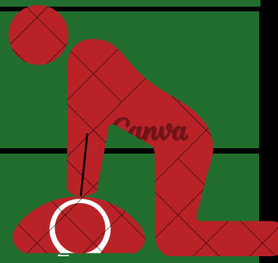
ระดับกองพล

บก.และร้อย.บก.

นายทหารยุทธการและการข่าว

ให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยเหลือ ผบ.พัน.สร. ในความรับผิดชอบ เรื่อง

* การรวบรวมข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
* จัดทำแผน/นโยบาย/โครงการ/วิธีการ พ.
* จัดหน่วยในการสนับสนุนการบริการ พ.
* แบ่งมอบ/กำกับดูแลการปฏิบัติของ นขต.
* ตรวจเยี่ยมทาง ฝอ.สำหรับ นขต.
* วางแผน/กำกับดูแล/ประสานงานการส่งกลับ โดยกำหนดเส้นทางส่งกลับร่วมกับ น.ฝ่ายส่งกำลังบำรุง
* วางแผน/กำกับดูแล การฝึกต่าง ๆ
* วางแผนสนับสนุนงาน กร. ของ กองพล
* วางแผน/กำกับดูแล การบริการ พ. สำหรับสงคราม ชคนร./สนบ./สงครามจิตวิทยา
* ทำแผนทางการ พ. สนับสนุนการป้องกัน พท.ส่วนหลัง/การควบคุม พท.
* วางแผน/กำกับดูแล/ควบคุมการส่งกลับ
* ปฏิบัติงาน กร. ของ พัน.สร.



นายทหารส่งกำลังบำรุง

ให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยเหลือ ผบ.พัน.สร. ในความรับผิดชอบ เรื่อง

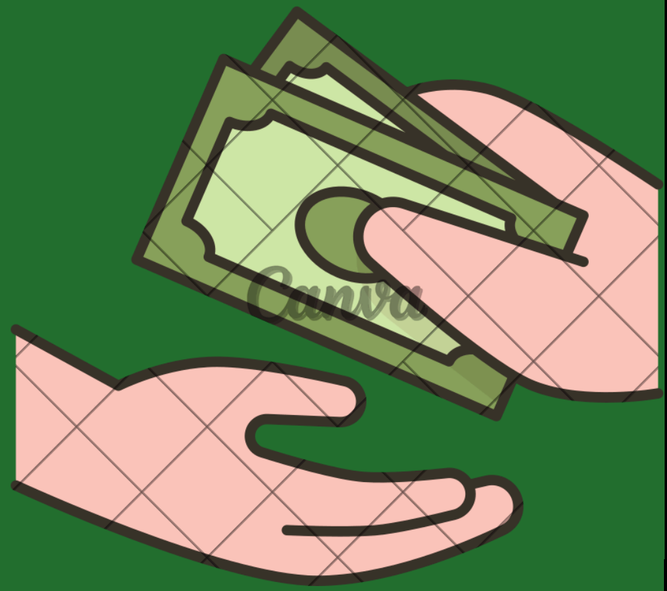
* กำหนดความต้องการ การส่งกำลัง
* แจกจ่ายยุทธภัณฑ์/สป.ให้ นขต.
* วางแผน/กำกับดูแล/ประสานงานส่งกลับ
* กำกับดูแล/ทำแผนสนับสนุนการป้องกัน พท.ส่วนหลัง
* กำกับดูแล การ ซบร./การจำหน่าย

นายทหารการเงิน

ให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยเหลือ ผบ.พัน.สร. ในความรับผิดชอบ เรื่อง

งานเกี่ยวกับการเงินของ พัน.สร.

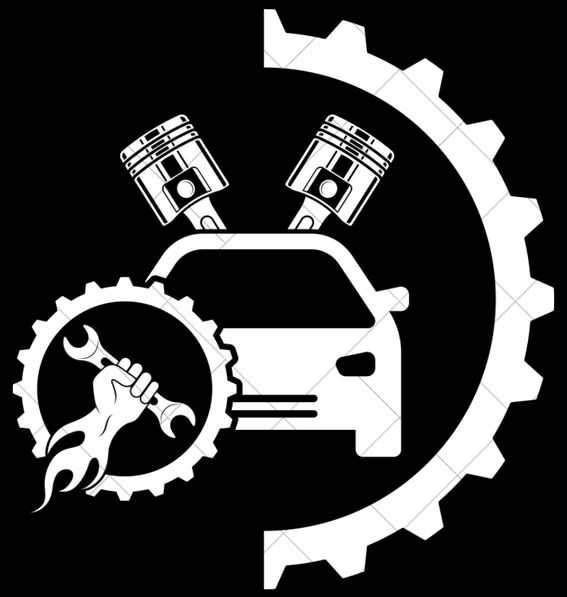
* เบี้ยเลี้ยง
* เงินเดือน
* เบี้ยเลี้ยงทหารเจ็บป่วยในการรบ
* เงินอื่น ๆ



หน้าที่ ร้อย.บก.พัน.สร.

* ควบคุมบังคับบัญชา กพ.ของ กองร้อย
* จัดตั้ง ทก.พัน.สร.
* ดำเนินงานธุรการของ กองร้อย
* วางข่ายการติดต่อสื่อสาร/ส่งกำลัง สป.2-4 สาย พ.
  - หน่วยในอัตราของ พัน.สร.
  - หน่วย พ. ที่มาสมทบ

บก.และร้อย.บก.



หน้าที่ ร้อย.บก.พัน.สร.

* ประกอบเลี้ยงให้กับ กพ.ของ
  - บก.พัน.สร.
  - ร้อย.บก.
  - ร้อย.สร.สน.
  - ทหารที่เจ็บป่วยที่รับไว้รักษา
* ซบร. ยานยนต์ล้อ
* ซบร.เครื่องมือ พ. ขั้นหน่วย

การส่งกำลัง สป. 2 , 4 สายแพทย์

น.ส่งกำลังบำรุง พัน.สร.ทำหน้าที่ 2 สถานะ

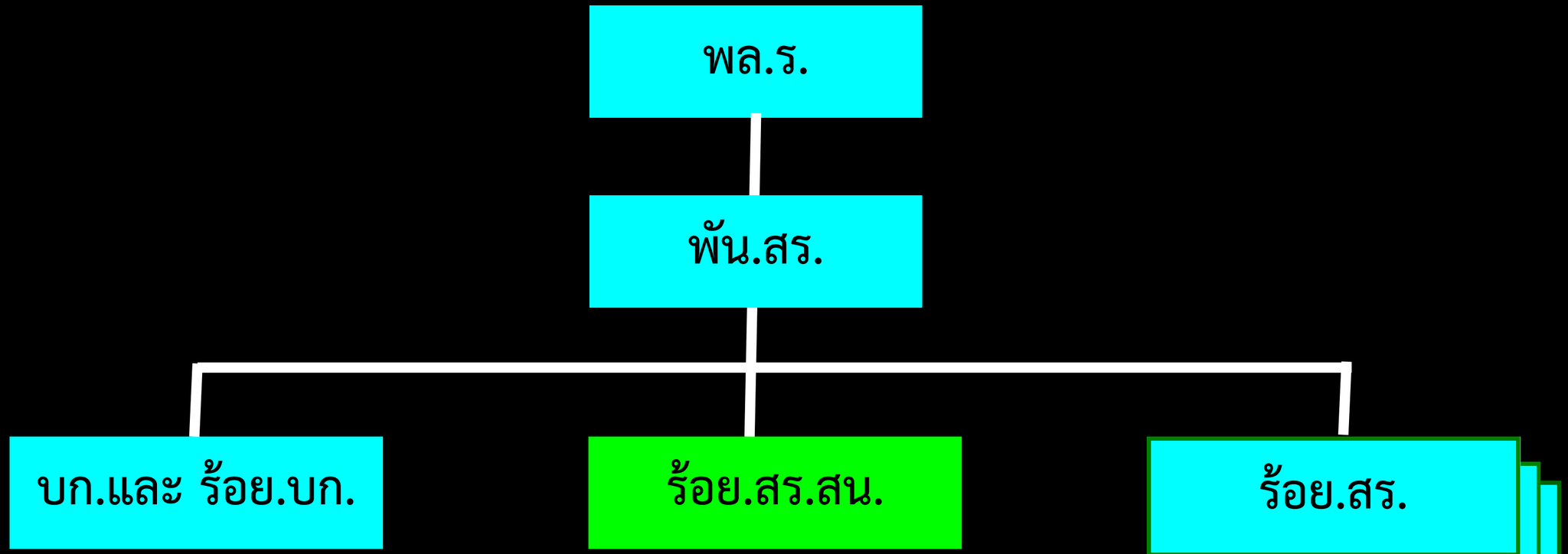
* เป็น น.ส่งกำลังทั่วไป ของ พัน.สร.

- ตอน บก.พัน./ส.ส่งกำลัง 2 นาย

* เป็น น.ส่งกำลังสาย พ. ของกองพล

- ตอนส่งกำลัง /น.ส่งกำลังสาย พ.

ร้อย.สร.สน.พัน.สร.พล.ร.



การบริการทางการแพทย์ ระดับกองพล

ร้อย.สร.สน.พัน.สร.พล.ร.

ภารกิจ

ให้การบริการแพทย์ระดับกองพล
ให้แก่หน่วยต่าง ๆ ใน **พื้นที่ส่วนหลัง** ของกองพล

การแบ่งมอบ

- จัดเป็น หน่วยในอัตรา ของ พัน.สร.
- จำนวน 1 ร้อย.สร.สน. / 1 พัน.สร.

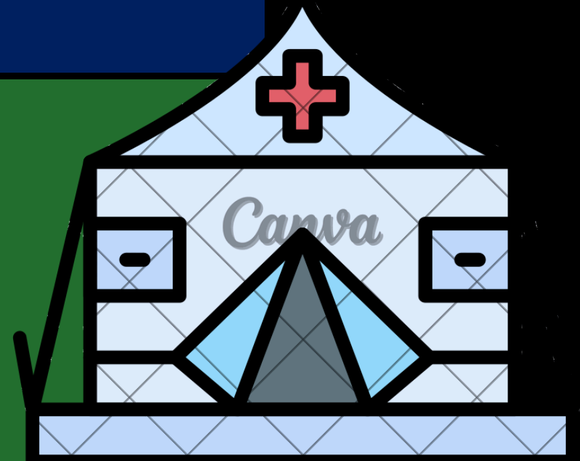
การบริการทางการแพทย์

ระดับกองพล

ร้อย.สร.สน.พัน.สร.พล.ร.

ขีดความสามารถ

* ตั้ง ที่พยาบาลกองพล 1 แห่ง
ในพื้นที่ส่วนหลังของกองพล
(รับ ผป.ได้ 80 คน ขยายได้สูงสุด 120 คน)



* รักษาโรคทาง อายุรกรรม
ศัลยกรรม ทันตกรรม
และตรวจวินิจฉัยทางรังสีกรรม ได้

* ส่งกลับ ผป.นอนได้ 24 คน
นั่งได้ 48 คน ต่อ 1 เที่ยว
(มี รยบ.ในอัตรา 6 คัน)

- ส่งกำลังและขนส่ง สป.2,4 ให้แก่หน่วย พ. ต่าง ๆ ในพื้นที่ส่วนหลังของกองพล
- เคลื่อนที่ด้วยตนเองได้ 100 %

อัตราเต็ม ๑๓๘ นาย (น.๑๑, สี.๓๔, พลฯ ๕๓)

หมายเหตุ อัตราการจัด ร้อย.สร.สนับสนุน พัน.สร.กรม สน.พล.ม. และ พล.ร.(ก.) ๘-๓๘ ม. (๒๕ ม.ค.๒๔) เหมือนกับการจัด ร้อย.สร.สนับสนุน พัน.สร.กรม สน.พล.ร. ตาม อจย.๘-๓๘ (๒๕ ม.ค.๒๔)

บก.ร้อย.สร.สน.พัน.สร.พล.ร.

ตำแหน่ง	ยศ	เต็ม	ลด2
ผบ.ร้อย.	พ.ต.	1	-
รอง ผบ.ร้อย	ร.อ.	1	1
จ่ากองร้อย	จ.(พ.)	1	1
ส.ส่งกำลัง	จ.	1	1
	ส.อ.	1	1
ส.ส่งกำลังสาย พ.	ส.อ.	1	1
พนักงานสลับสาย	ส.อ.	1	1
ส.ยานยนต์	จ.(พ.)	1	1
ช่างยานยนต์ล้อ	ส.อ.	2	1

ตำแหน่ง	ยศ	เต็ม	ลด2
พลประจำเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	ส.อ.	3	2
ส.ช่างอาวุธ	จ.	1	1
เสมียน	ส.อ.	1	1
พลขับรถ	ส.อ.	5	3
ทหารบริการ	พลฯ	11	7
พลลูกมือ	พลฯ	6	4
รวม		37	26
รยบ.1/4 ตัน = 1		รยบ.2 1/2 ตัน = 3	

การบริการทางการแพทย์
ระดับกองพล

มว.พยาบาล
ร้อย.สร.สน.พัน.สร.พล.ร.

ตำแหน่ง	ยศ	เต็ม	ลด2
ผบ.มว.	ร.อ.	1	1
ทันตแพทย์	ร.อ.	1	1
อายุรแพทย์	ร.อ.	1	-
ศัลยแพทย์	ร.อ.	1	1
น.ห้องผ่าตัด	ร.ท.	1	1
ส.ประจำ มว.	จ.(พ.)	1	1
ส.หน.ชุด	จ.	2	2
ส.อายุรกรรม	ส.อ.	4	2
ช่างยานยนต์ล้อ	ส.อ.	2	1

ตำแหน่ง	ยศ	เต็ม	ลด2
ส.ทันตกรรม	จ.	1	1
	ส.อ.	1	1
นายพวกเปล	ส.ต.	2	2
พลเปล	พลฯ	4	2
พลขับรถ	ส.อ.	7	5
พลลูกมือ	พลฯ	6	3
รวม		52	36

รยบ.3/4 ตัน = 1

รยบ.1/4 ตัน = 1

รยบ.2 1/2 ตัน = 3

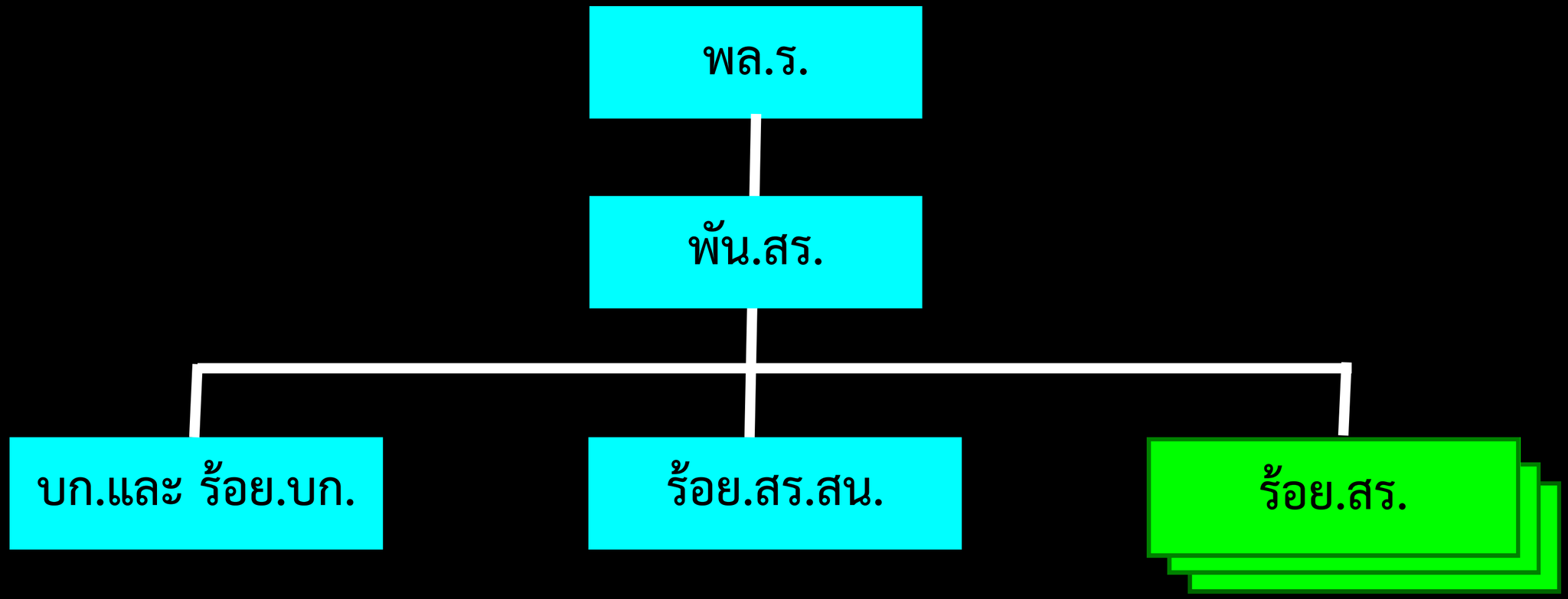
การบริการทางการแพทย์ ระดับกองพล

มว.ส่งกลับ ร้อย.สร.สน.พัน.สร.พล.ร.

ตำแหน่ง	ยศ	เต็ม	ลด2
บก.มว.	รยบ.1/4 ตัน = 1		
ผบ.มว.	ร.อ.	1	1
รอง ผบ.มว.	ร.ท.	1	-
ส.ประจำ มว.	จ.(พ.)	1	1
พลขับรถ	ส.อ.	3	1
รวม		6	3
ตอนรถยนต์พยาบาล	รยพ.3/4 ตัน = 6		
ผบ.ตอน	ร.ท.	1	1
รอง ผบ.ตอน	จ.	1	-

ตำแหน่ง	ยศ	เต็ม	ลด2
พลขับรถ	ส.อ.	6	4
นายสิบพยาบาล	ส.อ.	6	4
รวม		14	9
ตอนเปล			
ผบ.ตอน	ร.ท.	1	1
รอง ผบ.ตอน	จ.	1	-
ผบ.หมู่	ส.อ.	3	2
พลเปล	พลฯ	24	16
รวม		29	19

ร้อย.สร.พัน.สร.พล.ร.



การบริการทางการแพทย์ ระดับกองพล

ร้อย.สร.พัน.สร.พล.ร.

ภารกิจ

ให้การบริการแพทย์ระดับกองพล
(สนับสนุนเป็นพื้นที่) ในพื้นที่ กรม ร.

การแบ่งมอบ

- จัดเป็น หน่วยในอัตรา ของ พัน.สร.
- จำนวน 3 ร้อย.สร. / 1 พัน.สร.

การบริการทางการแพทย์
ระดับกองพล

ร้อย.สร.พัน.สร.พล.ร.

ขีดความสามารถ

* แต่ละกองร้อยตั้งที่พยาบาลกองพลหน้า 1 แห่ง
ในพื้นที่ขบวนสัมภาระของ กรม ร.
(สามารถรับ ผป.ได้ 80 คนขยายได้ 120 คน)

* รักษาโรคทาง
อายุรกรรม
ศัลยกรรม
ทันตกรรม

* ส่งกลับ ผป.นอนได้ 40 คน
นั่งได้ 80 คน ต่อ 1 เที่ยว
(มี รพย.ในอัตรา 10 คัน)

* ส่งกำลังและขนส่ง สป.2,4
ให้แก่หน่วย พ. ต่าง ๆ ในพื้นที่ กรม ร.
* เคลื่อนที่ด้วยตนเองได้ 100 %

ผังการจัดกองร้อยเสนารักษ์

อัตราเต็ม ๑๕๖ นาย (น.๑๑, ส.๘๑, พลฯ ๖๔)

หมายเหตุ อัตราการจัด ร้อย.สร.พัน.สร.กรม สน.พล.ม. และ พล.ร.(ก.) ตาม อจย.๘-๓๗ ม. (๒๕ ม.ค.๒๔) ที่แตกต่างจากอัตราการจัด ร้อย.สร.พัน.สร.กรม สน.พล.ร. ตาม อจย.๘-๓๗ (๒๕ ม.ค.๒๔) คือ **มว.ส่งกลับ** ไม่มี**ตอนเปล** อัตรากำลังพลจึงน้อยกว่า ซึ่งมีอัตรากำลังพลดังนี้.-

อัตราเต็ม ๑๒๗ นาย (น.๑๐, ส.๗๗, พลฯ ๔๐)

บก.ร้อย.สร.พัน.สร.พล.ร.

ตำแหน่ง	ยศ	เต็ม	ลด2
ผบ.ร้อย.	พ.ต.	1	1
รอง ผบ.ร้อย	ร.อ.	1	1
จ่ากองร้อย	จ.(พ.)	1	1
ส.สูทกรรม	จ.	1	1
ส.ส่งกำลัง	จ.	1	1
	ส.อ.	1	-
ส.ส่งกำลังสาย พ.	ส.อ.	1	1
พนักงานสลับสาย	ส.อ.	1	1
ส.ยานยนต์	จ.(พ.)	1	1

รยบ.1/4 ตัน = 1

รยบ.3/4 ตัน = 1

รยบ.2 1/2 ตัน = 1

ตำแหน่ง	ยศ	เต็ม	ลด2
พลสูทกรรม	ส.อ.	2	1
	ส.ต.	2	2
	พลฯ	7	3
เสมียน	ส.อ.	1	1
ช่างยานยนต์ล้อ	ส.อ.	2	1
พลวิทยุ	ส.อ.	1	1
พลขับรถ	ส.อ.	6	4
ส.ช่างอาวุธ	จ.	1	1
พลประจำเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	ส.อ.	3	2
ทหารบริการ	พลฯ	11	8
พลลูกมือ	พลฯ	6	4
รวม		51	35

มว.พยาบาลร้อย.สร.พัน.สร.พล.ร.

ตำแหน่ง	ยศ	เต็ม	ลด2
ผบ.มว.	ร.อ.	1	1
ทันตแพทย์	ร.อ.	1	1
อายุรแพทย์	ร.อ.	1	-
ศัลยแพทย์	ร.อ.	1	1
น.ห้องผ่าตัด	ร.ท.	1	1
ส.ประจำ มว.	จ.(พ.)	1	1
ส.หน.ชุด	จ.	2	2
ส.อายุรกรรม	ส.อ.	4	2
ส.วิสัญญี	จ.	2	2

รยบ.1/4 ตัน = 1

รยบ.2 1/2 ตัน = 4

รยบ.3/4 ตัน = 1

ตำแหน่ง	ยศ	เต็ม	ลด2
ส.ทันตกรรม	จ.	1	1
ส.พยาธิ	จ.	1	1
นายพวกเปล	ส.ต.	2	2
พลเปล	พลฯ	4	2
พลขับรถ	ส.อ.	6	4
พลลูกมือ	พลฯ	8	4
ส.ห้องผ่าตัด	จ.	1	1
	ส.อ.	4	2
ส.พยาบาล	จ.	3	2
	ส.อ.	5	3
รวม		48	33

การบริการทางการแพทย์
ระดับกองพล

มว.ส่งกลับ ร้อย.สร.พัน.สร.พล.ร.

ตำแหน่ง	ยศ	เต็ม	ลด2
บก.มว.			
ผบ.มว.	ร.อ.	1	1
รอง ผบ.มว.	ร.ท.	1	-
ส.ประจำ มว.	จ.(พ.)	1	1
พลขับรถ	ส.อ.	3	1
รวม		6	3
ตอนรถยนต์พยาบาล	รยพ.3/4 ตัน = 10		
ผบ.ตอน	ร.ท.	1	1
รอง ผบ.ตอน	จ.	1	-

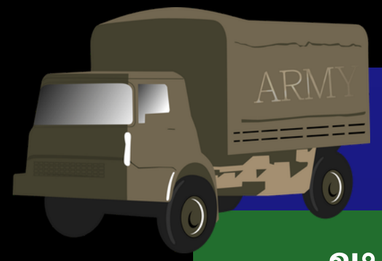
ตำแหน่ง	ยศ	เต็ม	ลด2
พลขับรถ	ส.อ.	10	7
นายสิบพยาบาล	ส.อ.	10	7
รวม		22	15
ตอนเปล			
ผบ.ตอน	ร.ท.	1	1
รอง ผบ.ตอน	จ.	1	-
ผบ.หมู่	ส.อ.	3	2
พลเปล	พลฯ	24	16
รวม		29	19

(พล.ม./พล.ร.ยก./พล.ปตอ. ไม่มี ตอนเปล)

การบริการทางการแพทย์

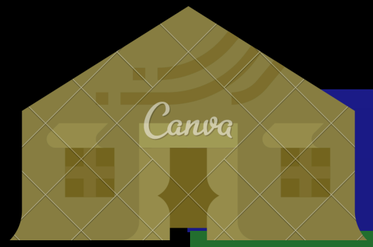
ระดับกองพล

ร้อย.สร.พัน.สร.พล.ร.



สรุปสถานภาพของยานพาหนะ

ขนาด/ประเภท	1/4	3/4	2 1/2	3/4 พยบ.	น้ำ
จำนวน(คัน)	3	2	8	10	-



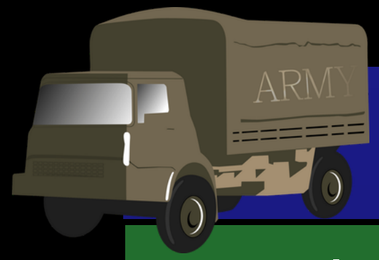
สรุปสถานภาพของ กระโจม

ขนาด/ประเภท	ทก.	อาหาร	ซบร.	S	M	L
จำนวน(หลัง)	-	2	-	3	8	4

การบริการทางการแพทย์

ระดับกองพล

ร้อย.สร.พัน.สร.พล.ร.



สรุปสถานภาพของยานพาหนะ

หน่วย/ประเภท	1/4	3/4	2 1/2	3/4 พยบ.	น้ำ
บก.และ ร้อย.บก.	6	3	9	-	1
ร้อย.สร.สน.	3	1	6	6	-
ร้อย.สร.	3	2	8	10	-
รวมทั้งสิ้น	12	6	23	16	1

สรุปสถานภาพของ กระโจม

ขนาด/ประเภท	ทก.	อาหาร	ซบร.	S	M	L
บก.และ ร้อย.บก.	2	1	1	2	2	-
ร้อย.สร.สน.	-	-	-	5	8	4
ร้อย.สร.	-	2	-	3	8	4
รวมทั้งสิ้น	2	3	1	10	18	8

การปฏิบัติงาน

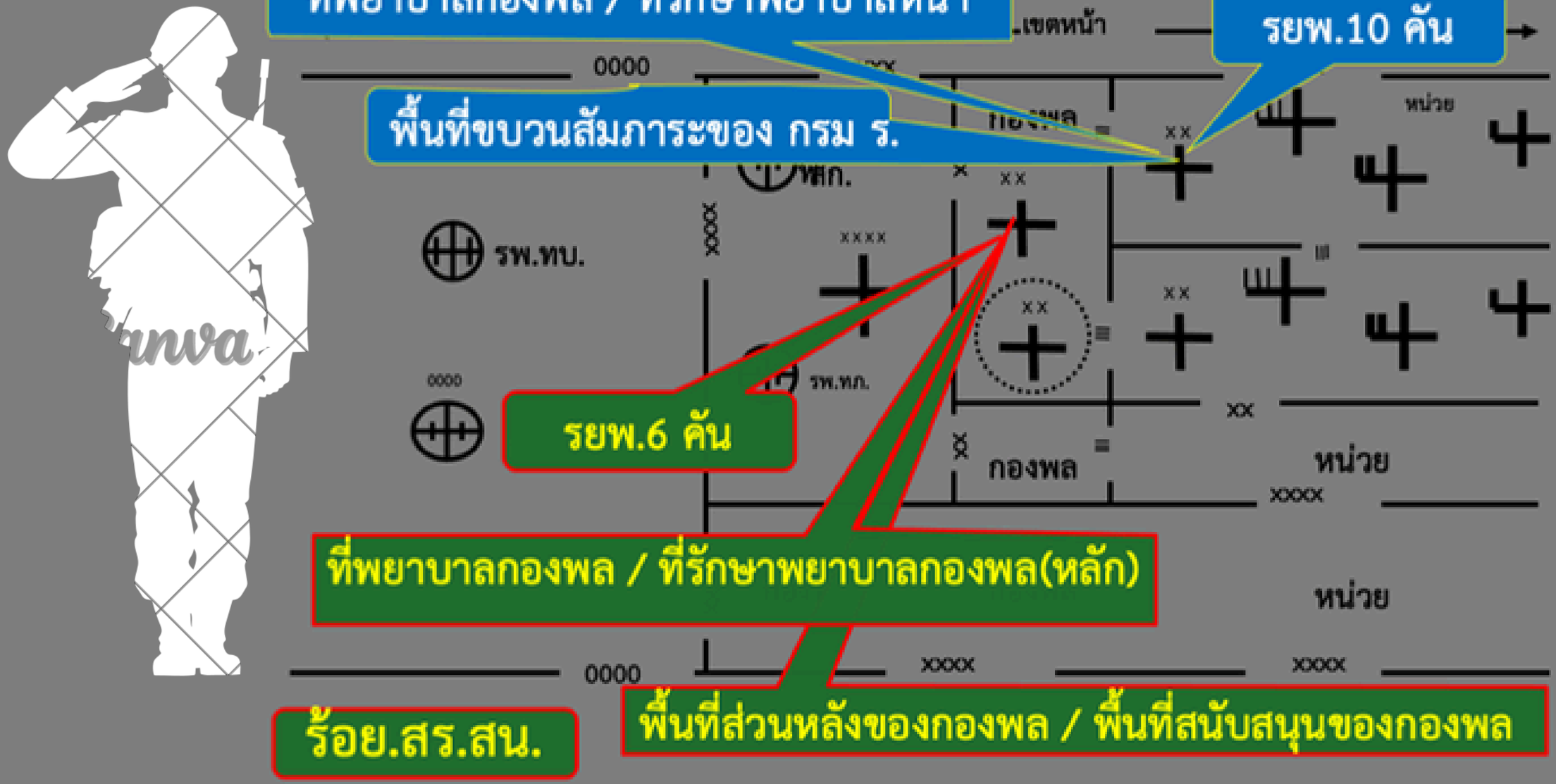
ร้อย.สร.สน. และ ร้อย.สร.

* มีรูปแบบการจัดหน่วยคล้ายคลึงกัน

* แตกต่างกันเฉพาะ
  - กำลังพลบางตำแหน่ง
  - สป.บางอย่าง
  - จำนวนรถยนต์พยาบาล

โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก
Army Medical Field Service School

การบริการทางการแพทย์ระดับกองพล



โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก
Army Medical Field Service School
การบริการทางการแพทย์ระดับกองพล
ร้อย.สร.
ที่พยาบาลกองพล / ที่รักษาพยาบาลหน้า
บรรจุ พลวิทยุ , ส.สูทกรรม
ไม่บรรจุ ส.รังสีกรรม , X-RAY
ไม่บรรจุ พลวิทยุ ส.สูทกรรม
ที่พยาบาลกองพล / ที่รักษาพยาบาลกองพล(หลัก)
บรรจุ ส.รังสีกรรม , เครื่อง X-RAY
ร้อย.สร.สน.
เขตยุทธบ
เขตหลัง
กองพล
หน่วย
สก.
รพ.ทบ.
ศพ.
กองทัพ
หน่วย
0000
xxxx
xxx
xx

การบริการทางการแพทย์

ระดับกองพล

พัน.สร.พล.ร.

สรุป ความแตกต่างของ ร้อย.สร.สน. กับ ร้อย.สร.

ร้อย สร.สน.

ขีดความสามารถ

1. จัดตั้งและดำเนินการที่พยาบาลกองพลได้ 1 แห่ง สามารถรับผู้ป่วยเจ็บได้ 80 คน และอาจขยายในกรณีจำเป็นได้ 120 คน
2. ทำการตรวจโรคทางรังสีกรรม และตรวจรักษาโรคทั้งทางอายุรกรรม ศัลยกรรม และทันตกรรม
3. ทำการส่งกลับผู้ป่วยเจ็บจากที่พยาบาลต่างๆ ในพื้นที่ส่วนหลังของกองพล มายังที่พยาบาลกองพล คนไข้นอน 24 คน นั่ง 48 คน ใน 1 เที่ยว
4. ทำการส่งกำลังและขนส่งสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ให้แก่หน่วยเสนารักษ์ต่างๆ ในพื้นที่ส่วนหลังของกองพล
5. เคลื่อนที่ด้วยตนเองได้ 100 %

ร้อย สร.

ขีดความสามารถ

1. จัดตั้งและดำเนินการที่พยาบาลกองพลหน้าได้ 1 แห่ง สามารถรับผู้ป่วยเจ็บได้ 80 คน และอาจขยายราวในกรณีจำเป็นได้ 120 คน
2. ทำการตรวจรักษาทางอายุรกรรม ศัลยกรรม และ ทันตกรรม
3. ทำการส่งกลับผู้ป่วยเจ็บจากที่พยาบาลต่างๆ ในพื้นที่กรมทหารราบ มายังที่พยาบาลกองพลหน้า คนไข้นอน 40 คน นั่ง 80 คน ใน 1 เที่ยว
4. ทำการส่งกำลังและขนส่งสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ให้แก่หน่วยเสนารักษ์ต่างๆ ในพื้นที่ของกรมทหารราบ
5. เคลื่อนที่ด้วยตนเองได้ 100 %

สรุป ความแตกต่างของ ร้อย.สร.สน. กับ ร้อย.สร.

ร้อย สร.สน.

- ไม่มีพลวิทยุ และวิทยุในอัตรา (ใช้การติดต่อสื่อสารร่วมกับ ทก.พัน.สร.)
- ไม่มีนายสิบสูทกรรมและชุดสูทภัณฑ์ในอัตรา (ได้รับการเลี้ยงดูจาก ร้อย.บก.พัน.สร.)
- มีรถยนต์พยาบาล 6 คัน

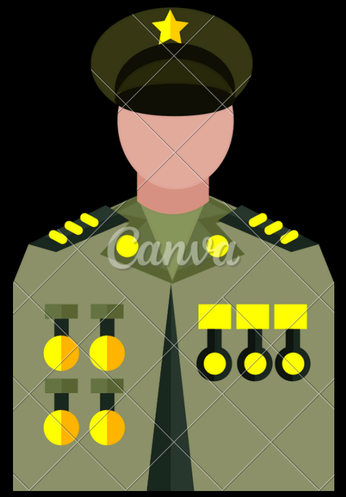
ร้อย สร.

- มีพลวิทยุ และวิทยุอยู่ในอัตรา
- มีนายสิบสูทกรรม และชุดสูทภัณฑ์ในอัตรา
- มีรถยนต์พยาบาล 10 คัน

ร้อย สร.สน.

การปฏิบัติงานของ บก.ร้อย.

ร้อย สร.



* ใน บก.ร้อย.

- ผบ.ร้อย. เป็นผู้บังคับบัญชา
- รอง ผบ.ร้อย.เป็น ผู้ช่วย

* ประกอบด้วย จนท.ตำแหน่งต่าง ๆ

เช่น จนท.สูทกรรม

+ มี ใน ร้อย.สร.
- ไม่มีใน ร้อย.สร.สน.

ร้อย สร.สน.

การปฏิบัติงานของ บก.ร้อย.

ร้อย สร.

ผบ.ร้อย. เปิดที่พยาบาลกองพล ขึ้นตามความจำเป็นของสถานการณ์

* บริการ พ. เป็นพื้นที่ (หน่วยที่ไม่มีสาย พ.)
* ประสานการปฏิบัติหน่วยที่เกี่ยวข้อง
* จัดตั้ง ศูนย์ข่าว
* กำหนดแนวทางการส่งกลับให้ ผบ.มว.
* ประสานการส่งกลับ /กำหนดที่กอง สป.

การปฏิบัติงานของ มว.พยาบาล

ร้อย สร.สน.

เป็นหน่วยหลัก ในการรักษาพยาบาล

* จำนวนวันที่สามารถรับ ผป.ไว้รักษาเป็นไปตามนโยบายส่งกลับที่กำหนด

* มี จนท.ดำเนินการรับ-คัดแยก ผป. เพื่อให้การรักษาพยาบาลเพิ่มเติม

ร้อย สร.

นอกสถานการณ์รบ

* การรักษาพยาบาลจำกัดอยู่เพียงให้การรักษา ผป. ซึ่งจะทำการบำบัดให้หายแล้วกลับไปรับหน้าที่ได้ในเวลาอันสั้นเท่านั้น นอกจากนั้นต้องรีบส่งกลับ

ร้อย สร.สน.

การปฏิบัติงานของ มว.พยาบาล

ร้อย สร.

ในสถานการณ์รบ

* เปิด ที่พยาบาลกองพล
* รับ ผป./คัดแยก/ให้การรักษาพยาบาล
* ส่งคืน
* ส่งกลับ ไปยังการบริการแพทย์ระดับกองทัพ ที่ให้การสนับสนุนต่อไป

การบริการทางการแพทย์
ระดับกองพล

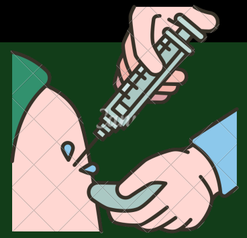
พัน.สร.พล.ร.

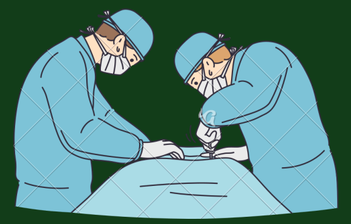
ร้อย สร.สน.

ขีดความสามารถของ ที่พยาบาลกองพล

ร้อย สร.

* ช่วยชีวิตฉุกเฉิน
* รักษาด้าน
  - อายุรกรรม
  - ศัลยกรรม
  - ทันตกรรม ได้อย่างจำกัด
* ตรวจวินิจฉัย**ทางรังสีกรรม** {เฉพาะที่พยาบาลกองพล}
* ตรวจทางห้องปฏิบัติการ/ให้โลหิต





การบริการทางการแพทย์
ระดับกองพล

พัน.สร.พล.ร.

ร้อย สร.สน.

หน้าที่ของ ผบ.มว.พยาบาล

ร้อย สร.

- ปกครองบังคับบัญชา ธุรการการฝึกใน มว.
- จัดตั้ง และดำเนินการ ที่พยาบาลกองพล
- รายงานสถานภาพของ มว.ต่อ ผบ.ร้อย.
- แจ้งสถานภาพของ ผป. ซึ่งคอยการส่งกลับให้ จนท.ที่ทำการส่งกลับในหน่วยทราบ เพื่อช่วยให้การเตรียมการส่งกลับ สะดวก/รวดเร็ว
- ติดตามสถานการณ์โดยต่อเนื่อง
- ดำรงการติดต่อ มว.ส่งกลับ ที่ ปฏิบัติงานใน พื้นที่ข้างหน้า
- ติดต่อประสานงานกับ รยพ.ของ หน่วย พ. ที่มาสนับสนุน

ร้อย สร.สน.

การจัดตั้ง ที่พยาบาลกองพล

ร้อย สร.

* จัดตั้ง ที่พยาบาลกองพล (ไม่ช้ากว่า 1 ชม. หลังจากที่พยาบาลกองพัน จัดตั้งแล้ว)

* ลักษณะการจัดตั้งต้องเปลี่ยนแปลงไปตาม ภารกิจ / ภูมิประเทศ / จำนวนผู้ป่วยเจ็บ

* จัดตั้งครั้งแรกให้พอสำหรับการปฏิบัติภารกิจเท่านั้น

ร้อย สร.สน.

การจัดตั้ง ที่พยาบาลกองพล

ร้อย สร.

* การจัดระเบียบภายใน ให้เป็นไปในลักษณะเดินทางเดียว ในขั้นต้นการจัดระเบียบ ควร ประกอบด้วย

- ตอนรับคนไข้
- ตอนอายุรกรรม
- ตอนศัลยกรรม
- ตอนดูแลผู้ป่วยเจ็บ

พัน.ร.

ที่พยาบาลกองพล

ทางเข้า

ทางออก

H

ตอนรับคัดไข้

เล็กน้อย–ทันที–รอได้

ตอนอายุรกรรม

ตอนดูแลผู้ป่วยเจ็บ

ตอนศัลยกรรม

มว.พยาบาล

ทก.ร้อย

เวชภัณฑ์

มว.ส่งกลับ

ครัว

ห้องน้ำ

ศพ

ผู้ป่วยมีความคาดหวัง

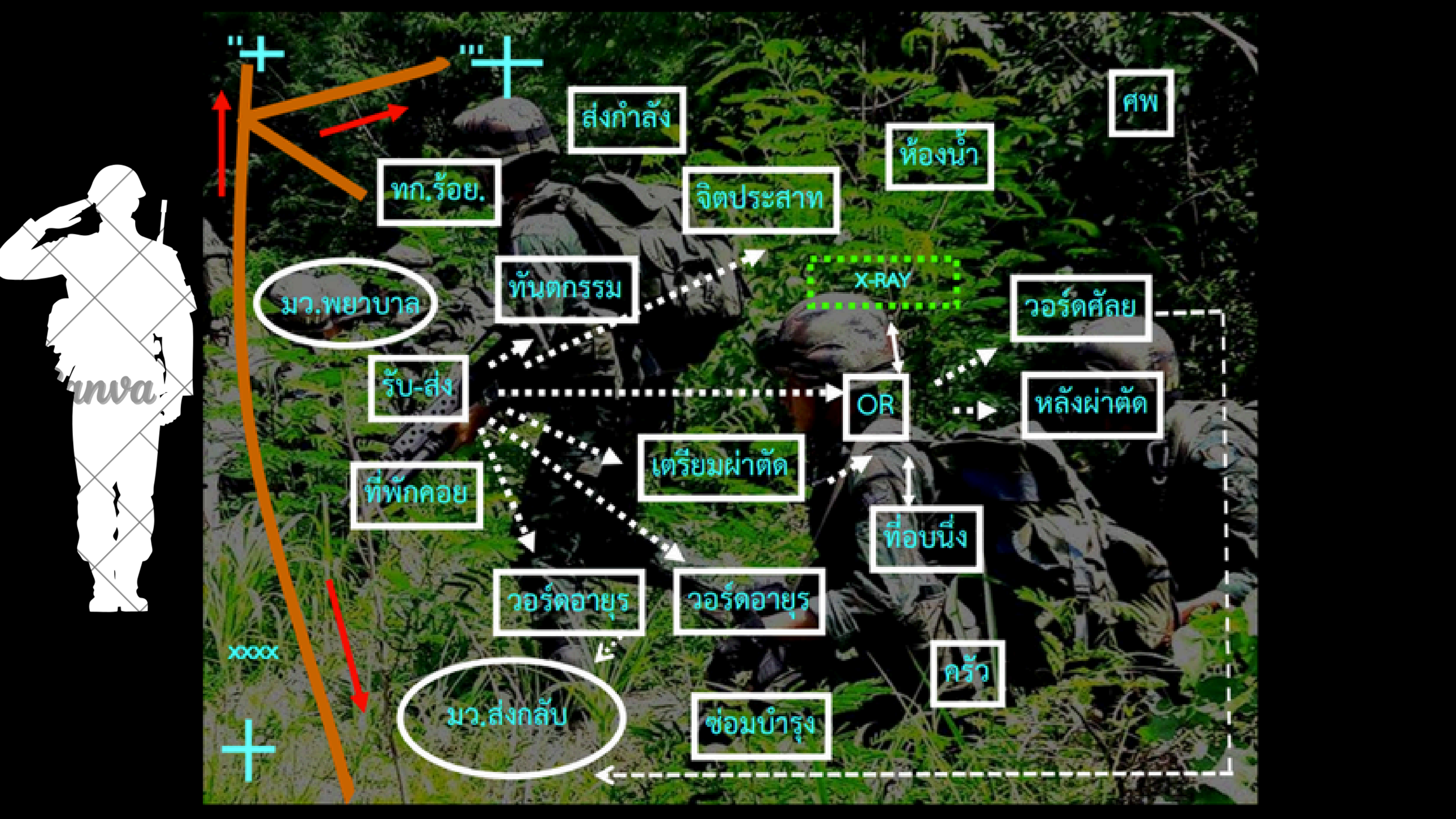
นซค.

(ใต้ลม)

ทางเข้า

ทางออก

ที่พยาบาล
กองทัพ


ส่งกำลัง
ศพ
ทก.ร้อย.
ห้องน้ำ
จิตประสาท
X-RAY
มว.พยาบาล
ทันตกรรม
วอร์ดศัลย
รับ-ส่ง
OR
หลังผ่าตัด
เตรียมผ่าตัด
ที่พักคอย
ที่อบนึ่ง
วอร์ดอายุร
วอร์ดอายุร
ครัว
มว.ส่งกลับ
ซ่อมบำรุง

ร้อย สร.สน.

การเลือกที่ตั้ง ที่พยาบาลกองพล

ร้อย สร.

จำนวนของ ที่พยาบาลกองพล ต้อง**เป็นไปตามแผนของผู้บัญชาการกองพล** โดยจะกำหนดไว้ใน คำสั่งการช่วยรบของกองพล

(ข้อ 5. การส่งกลับสายแพทย์และการรักษาพยาบาล)

สำหรับแผนการช่วยรบ เป็นแบบฟอร์มเช่นเดียวกับคำสั่งการช่วยรบนั่นเอง แต่มีข่าวสารเกี่ยวกับ “สมมุติฐาน” และให้บ่งเวลาหรือสภาวการณ์ ซึ่งแผนนั้นจะมีผลบังคับใช้ ซึ่งมีหัวข้อหลัก ๙ ข้อ ดังนี้.-

๑. สถานการณ์
๒. ภารกิจ
๓. กล่าวทั่วไป
๔. ยุทโธปกรณ์และบริการ
๕. การส่งกลับสายแพทย์และการรักษาพยาบาล
๖. การกำลังพล
๗. กิจการพลเรือน
๘. เบ็ดเตล็ด
๙. การบังคับบัญชาและการติดต่อสื่อสาร

ร้อย สร.สน.

การเลือกที่ตั้ง ที่พยาบาลกองพล

ร้อย สร.

โดยปกติการเลือกบริเวณที่จะจัดตั้ง ที่พยาบาลกองพล โดยทั่วไปผู้กำหนด ได้แก่

* ในพื้นที่ส่วนหลังของกองพล

นายทหารฝ่ายส่งกำลังบำรุง (สธ.4 พล.)

* ใน พื้นที่ขบวนสัมภาระ กรม ร.

นายทหารฝ่ายส่งกำลังบำรุง (ฝอ.4 กรม)

1 ร้อย.สร./ 1 กรม ร.

การเลือกที่ตั้ง ที่พยาบาลกองพล

ร้อย สร.สน.

ร้อย สร.

1 แห่งใน พท.ส่วนหลังกองพล

1 ร้อย.สร.จัด 1 แห่งใน พท.ขบวนสัมพันธ์ กรม สร.

การเลือกที่ตั้งโดยแน่นอน

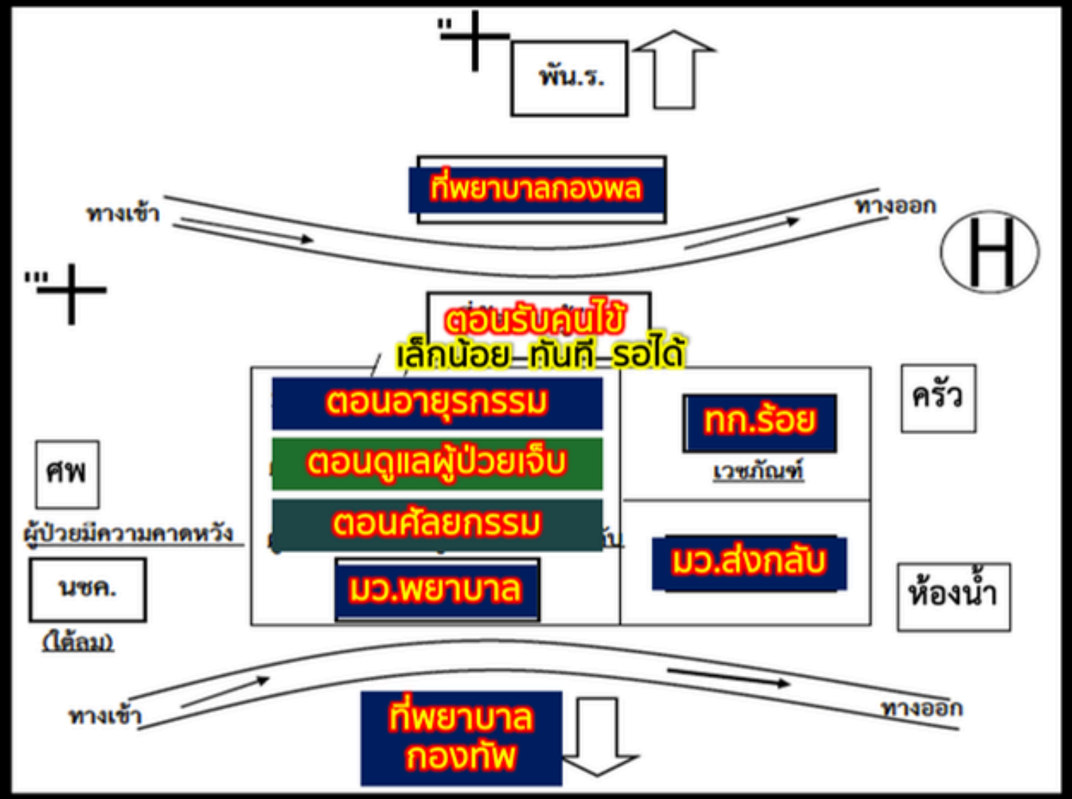
* ที่พยาบาลกองพล
  - ผบ.ร้อย.สร.สน. เป็นผู้เลือก
* ที่พยาบาลกองพลหน้า
  - ผบ.ร้อย.สร. เป็นผู้เลือก

* เว้นแต่จะระบุใน คำสั่ง พัน.สร.พล

ร้อย สร.สน.

การเลือกที่ตั้ง ที่พยาบาลกองพล

ร้อย สร.



* มีทางติดต่อกับเส้นทางส่งกลับ/สนาม ฮ.
* อยู่พ้นระยะยิงของ ป.ของข้าศึก
* มีการจัดทำบังเกอร์รอบ ๆ ที่ตั้งหน่วย
* มีที่กว้างขวางพอที่จะขยายในอนาคต
* ต้องมีน้ำอย่างเพียงพอ

ร้อย สร.สน.

ปัจจัยในการเลือกที่ตั้งที่พยาบาลกองพล

ร้อย สร.

* แผนของผู้บังคับบัญชา
* เส้นทางส่งกลับ (ทั้งจากข้างหน้า และ ข้างหลัง)
* พื้นที่คาดว่าจะมีผู้ป่วยเจ็บหนาแน่น
* ระยะทางของการส่งกลับ
* พื้นที่แข็ง ระบายน้ำได้ดี
* การติดต่อสื่อสาร
* ห่างลักษณะที่เป็นเป้าหมายของ ขศ.
* มีพื้นที่จัดทำสนาม ฮ.
* การกำบังและการซ่อนพราง
* ความปลอดภัยโดยรอบบริเวณที่ตั้งหน่วย

การบริการทางการแพทย์
ระดับกองพล

พัน.สร.พล.ร.

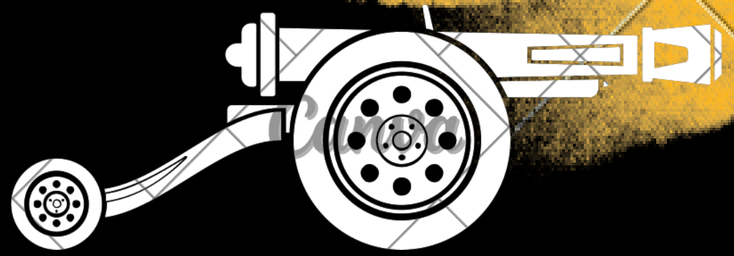
ร้อย สร.สน.

ร้อย สร.

ลักษณะที่ไม่เหมาะ
ในการจัดตั้งที่พยาบาลกองพล

* พื้นที่ที่อำนวยให้สารเคมีตกค้างอยู่นานโดยทั่วไปเป็นที่ต่ำและป่าทึบ

* ใกล้ชิดกับเป้าหมายหรือที่ตั้งที่สำคัญในการโจมตีของข้าศึก



ร้อย สร.สน.

การปฏิบัติงาน

ร้อย สร.

* การพรางที่ตั้งหน่วยเป็นไปตามนโยบายของ ผู้บัญชาการกองพล
* ควรมีเครื่องหมายชี้ทางตามตำบลที่สำคัญบนเส้นทางรถยนต์พยาบาล
* ถ้าเป็นไปได้ การเคลื่อนย้ายที่พยาบาลกองพล ควรกระทำพร้อมกันในครั้งเดียว แต่ถ้าจำเป็นสามารถเคลื่อนย้ายตามลำดับขั้นได้
* ผป. ที่ส่งกลับ จะเกิดขึ้นเป็นระยะไม่สม่ำเสมอ และมีจำนวนหลายราย ดังนั้น การคัดแยกจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ

ร้อย สร.สน.

การปฏิบัติงาน

ร้อย สร.

ผป.บางรายที่จะส่งกลับ แต่ยังเคลื่อนย้ายไม่ได้ อาจจะต้องแยกเพื่อส่งไปรักษายัง

- ชุดศัลยกรรมเคลื่อนที่ของ ทบ. ซึ่ง ทบ.อาจจัดมาสนับสนุน (ตามอนุผนวก 1 การปฏิบัติเมื่อ ทบ.ให้จัดชุดศัลยกรรมเคลื่อนที่เพิ่มเติมขีดความสามารถแก่หน่วยรักษาพยาบาลประกอบคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)ที่ 134/31ลง 14 มิ.ย. 31)

ร้อย สร.สน.

การปฏิบัติงาน

ร้อย สร.

* แต่ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุน ชุดศัลยกรรมเคลื่อนที่ ก็จะต้องดูแลรักษา ผป. ไว้ต่อไปโดยไม่มีกำหนด จนกว่าอาการจะดีขึ้นและพร้อมส่งกลับไปยัง ที่พยาบาลกองทัพ (ร้อย.สร.สน.พัน.สร.บชร. สนธิกำลังกับ 1 ชุดรักษาพยาบาล + 1 ชุด ศัลยกรรมสนาม ของหน่วยศัลยกรรมสนาม)

ร้อย สร.สน.

บันทึกทางการแพทย์

ร้อย สร.

ผป.ที่ไม่มี บัตรบันทึกการเจ็บป่วยในสนาม (ทบ.466-901) ติดตัวมาด้วย ที่พยาบาลกองพล จะต้องจัดทำให้

- แบบ ทบ.466-901 นี้จะติดตัว ผป.ตลอดเวลาในการส่งกลับ
- จะปลดออกเมื่อ ผป.เสียชีวิต หรือ ส่งคืน

ร้อย สร.สน.

บันทึกทางการแพทย์

ร้อย สร.

รายงานสถานภาพผู้ป่วยเจ็บ จะถูกส่งผ่าน พญ.พล. ไปยัง สธ.1 พล.ตามกำหนด เวลาในรายงานจะประกอบด้วย

- บัญชีรายชื่อ ผป.ที่รับไว้ทั้งหมด พร้อมหมายเลขประจำตัว/สังกัด
- สาเหตุที่รับ และจำหน่าย

ร้อย สร.สน.

บันทึกทางการแพทย์

ร้อย สร.

แบบบันทึกทางการแพทย์ ทุกแบบเป็นเอกสารที่สำคัญมาก ทำให้ทราบ

- ยศ ชื่อ สังกัด / อาการเจ็บป่วย
- การรักษาพยาบาล/สาเหตุที่รับและจำหน่าย
- เป็นหลักฐานที่จะนำมาประกอบการพิจารณาปูนบำเหน็จความชอบต่อไป

การบริการทางการแพทย์
ระดับกองพล

พัน.สร.พล.ร.

ร้อย สร.สน.

บันทึกทางการแพทย์

ร้อย สร.

ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการรักษาพยาบาลและส่งกลับในสนาม พ.ศ.2514

* รายงานการรักษาพยาบาลและส่งกลับในสนาม (ทบ.466 - 900)
* บัตรบันทึกการเจ็บป่วยในสนาม (ทบ.466 - 901)
* บัตรทึกสำหรับคนไข้ส่งกลับ (สนาม) (ทบ.466 - 902)
* บัตรส่งสิ่งของคนไข้ (สนาม) (ทบ.466 - 903)
* ใบชันสูตรพลิกศพ (สนาม) (ทบ.466 - 904)

ร้อย สร.สน.

การจำหน่ายผู้ป่วยเจ็บ

ร้อย สร.

ผป.ที่รักษาพยาบาลอยู่ ณ ที่พยาบาลกองพล (ยกเว้นพวกที่ถึงแก่กรรม) จะถูกจำหน่ายด้วยวิธี

* การส่งกลับ
* การส่งคืน

ร้อย สร.สน.

การจำหน่ายผู้ป่วยเจ็บ

ร้อย สร.

การส่งกลับ (ไปยังที่พยาบาลกองทัพ)

* ปิดบันทึกทางการแพทย์
* ลงรายละเอียดในแบบ ทบ.466-901
* อาวุธประจำกาย ของ ผป. จะถูกรวบรวมส่งไปยังนายทหารส่งกำลัง ของ พัน.สร. เพื่อส่งกลับไปข้างหลังหรือตามนโยบายของ ผบ.พล.

ร้อย สร.สน.

การจำหน่ายผู้ป่วยเจ็บ

ร้อย สร.

การส่งคืน - ต้องคืนยุทโธปกรณ์ และสิ่งของต่าง ๆ ของ ผป.ที่ได้ปลดไว้ให้กับ ผป.ให้ครบตามจำนวนที่ได้เก็บรักษาไว้

กระทำได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับสถานการณ์

1. ในพื้นที่ส่วนหลังของกองพล ส่งไปยังกองร้อยกำลังทดแทน
2. ฝากไปกับยานพาหนะของหน่วยที่ผ่านมา
3. ฝากไปกับรถยนต์พยาบาลที่ไปทำการส่งกลับผู้ป่วยเจ็บ
4. ชี้เส้นทางให้เดินไปเอง

ร้อย สร.สน.

การจำหน่ายผู้ป่วยเจ็บ

ร้อย สร.

ผู้ป่วยเจ็บถึงแก่กรรม

* เมื่อมี ผป.ถึงแก่กรรมใน ที่พยาบาลกองพล ต้องแจ้งให้ จนท.ที่รับผิดชอบการส่งกลับ ผป. ได้ทราบ

* ปิดบันทึกทางการแพทย์สำหรับ ผป. รายนั้น

* แจ้ง มว.พยาบาล / ทก.ร้อย. เพื่อแจ้ง หน่วยการศพสนาม ให้มาดำเนินการต่อไป

ร้อย สร.สน.

การจำหน่ายผู้ป่วยเจ็บ

ร้อย สร.

เอกสารบันทึกการจำหน่าย ผป.

* ทั้งจากการ ส่งกลับ / ส่งคืน / ถึงแก่กรรม จนท.ที่รับผิดชอบการส่งกลับ จะต้องรวบรวมส่งไปเก็บไว้ที่ มว.พยาบาล
* มว.พยาบาล สรุปทำรายงานระบุปลายทางการจำหน่าย
* เสนอผ่าน ทก.ร้อย./ทก.พัน.สร./พญ.พล.

ร้อย สร.สน.

การจำหน่ายผู้ป่วยเจ็บ

ร้อย สร.

เชลยศึก

- การจำหน่าย ปฏิบัติเช่นเดียวกับ ผป.ฝ่ายเรา
- การควบคุมตัวในการส่งกลับ
  - * ผู้มีอำนาจชั้นเหนือ เป็นผู้สั่งการ
  - * ผู้ควบคุมต้องจัดจากหน่วยอื่น (สห.)
- ในระหว่างการรักษาอาจใช้งานเชลยศึกได้
- การกักตัวเชลยศึกไว้ทำงาน เป็นการตกลงใจของ ผบช.ชั้นเหนือ

ร้อย สร.สน.

การจำหน่ายผู้ป่วยเจ็บ

ร้อย สร.

การส่งกลับจาก ที่พยาบาลกองพล

* เป็นหน้าที่ของ ที่พยาบาลกองทัพ

- สธ.4 กองพล ทำความตกลงกับ ทภ. /พญ.พล.เป็นผู้เสนอแนะ / ในทางปฏิบัติส่วนมากจะให้ พญ.พล.เป็นผู้ดำเนินการ

- วิธีการส่งกลับอาจจัดตามตาราง ชม.ที่กำหนด / ตามร้องขอ

ร้อย สร.สน.

การจำหน่ายผู้ป่วยเจ็บ

ร้อย สร.

การส่งกลับจาก ที่พยาบาลกองพล

* ในการส่งกลับด้วย รยพ. หน่วยจะต้องตอบรับการมาถึงของ รยพ. ด้วย
* คำร้องขอการส่งกลับจะต้อง ระบุจำนวน /ชนิดของการบรรทุก (นั่ง,นอน)
* ความล่าช้า ระหว่างรอการส่งกลับ/การเคลื่อนที่ ของ รยพ. ต้องนำมาพิจารณาด้วย

นโยบายการส่งกลับ
EVACUATION POLICIES

ระยะเวลาในการเก็บผู้ป่วยเจ็บไว้รักษาพยาบาลตามขีดความสามารถ

ทภ.กำหนดนโยบายส่งกลับให้หน่วยรักษาพยาบลในสนามซึ่งเป็นหน่วยรอง ของตนต่อไป โดย**มิให้เกินนโยบายการส่งกลับ ที่ ทบ.กำหนดให้**

กองพล กำหนดนโยบายส่งกลับให้ หน่วยทางการแพทย์ของตน โดย**ไม่ให้เกินนโยบายส่งกลับที่ ทภ.กำหนดให้**กับกองพล

นโยบายการส่งกลับของกองพล

* นโยบายการส่งกลับของกองพล เป็นไปตามนโยบายหน่วยเหนือที่กำหนด

* ทั้งนี้เพื่อป้องกันการสูญเสียกำลังพลโดยไม่จำเป็น

* ต้องคำนึงห้วงระยะเวลาด้วย **ถ้าสั้นเกินไปก็จะเกิดการสะสม ผป. ในหน่วยข้างหลัง**

นโยบายการส่งกลับ

ระเบียบ และ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

* ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการรักษาพยาบาลและส่งกลับในสนาม พ.ศ.2514 ลง 26 พ.ค.14
* รปจ.การส่งกำลังบำรุงสนับสนุนหน่วยปฏิบัติ ของ ทบ. (บก.ทบ.ที่ ชย.31 ลง 14 มิ.ย.31)
* รปจ.การส่งกำลังบำรุงสนับสนุนหน่วยในสนาม ของแต่ละ ทภ.
* คำสั่งการช่วยรบ ของแต่ละ กองพล (การรักษาพยาบาลและการส่งกลับ)

นโยบายการส่งกลับ

* ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการรักษาพยาบาลและ ส่งกลับในสนาม พ.ศ.2514 ลง 26 พ.ค.14

ข้อ 10 นโยบายการส่งกลับ

10.1 หน่วยเหนือมีหน้าที่กำหนดนโยบายส่งกลับให้แก่หน่วยรอง

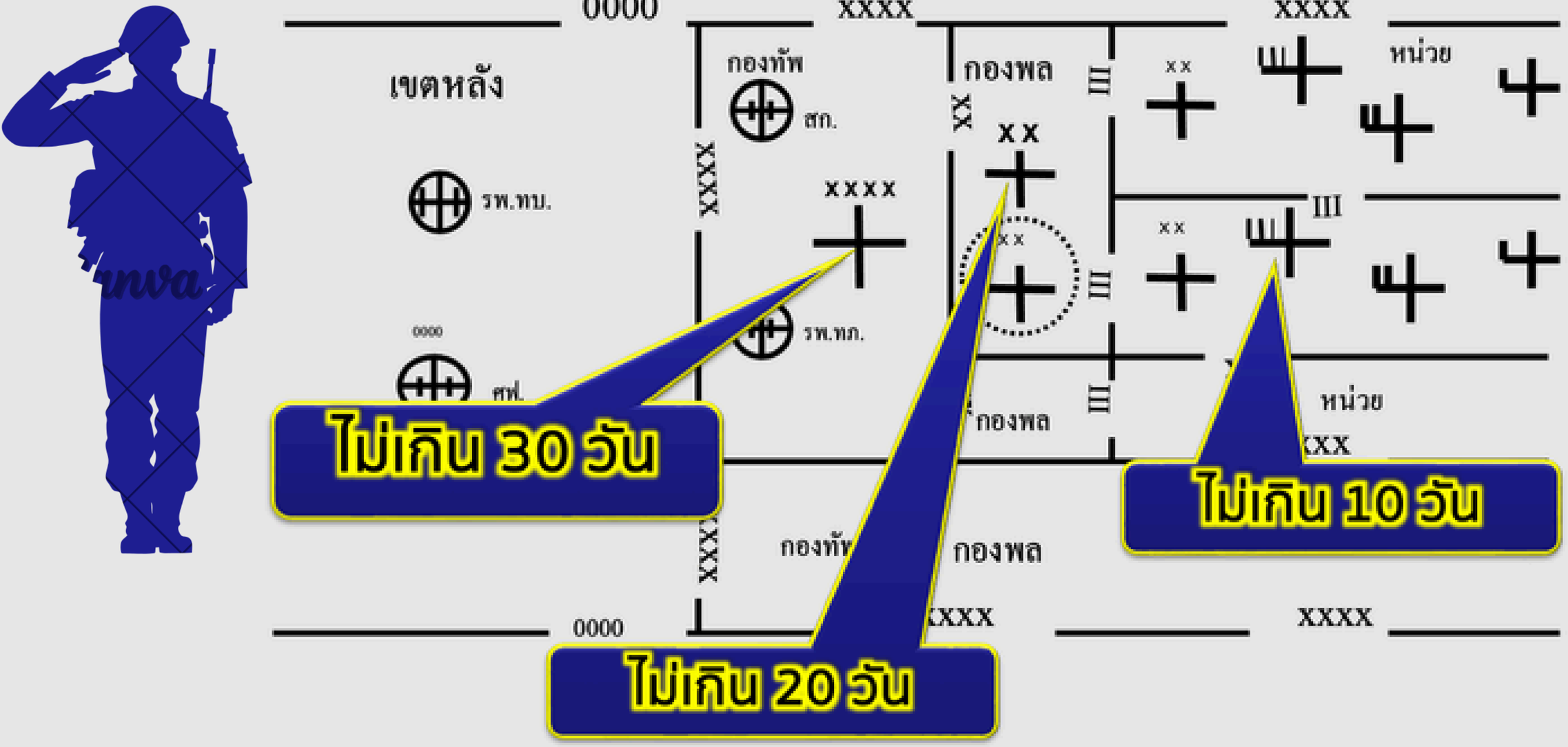
10.2 ให้ถือเกณฑ์นโยบายการส่งกลับโดยทั่วไป ดังนี้

10.2.1 ที่พยาบาลกรมไม่เกิน 10 วัน

10.2.2 ที่พยาบาลกองพลไม่เกิน 20 วัน

10.2.3 หน่วยรักษาพยาบาลที่สนับสนุน ระดับกองทัพไม่เกิน 30 วัน

นโยบายการส่งกลับ



มว.ส่งกลับ ร้อย.สร.สน.

- บก.มว.
- ตอนรถยนต์พยาบาล
- ตอนเปล

- รยพ. 1 1/4 ตัน จำนวน 6 คัน

การปฏิบัติของ มว. ส่งกลับ

มว.ส่งกลับ ร้อย.สร.

- บก.มว.
- ตอนรถยนต์พยาบาล
- ตอนเปล

- รยพ. 1 1/4 ตัน จำนวน 10 คัน

ผบ.มว.ส่งกลับ

มีหน้าที่

* รับแผนปฏิบัติจาก ผบ.ร้อย.
* วางแผนการใช้ เครื่องมือส่งกลับ โดยศึกษา
  - สถานการณ์ทางยุทธวิธี
  - ภูมิประเทศ / ลมฟ้าอากาศ
  - เส้นหลักการส่งกำลัง (เพื่อกำหนด เส้นทางการส่งกลับ)

ร้อย สร.สน.

มว.ส่งกลับ

ร้อย สร.

ผบ.มว.ส่งกลับ

ความรับผิดชอบ

* จัดตั้ง/ตรวจตรา/ควบคุมการบริการ รยพ. ตั้งแต่เริ่มต้น จนสิ้นสุด
* เตรียมที่พัก/ ความสะดวก/ การเลี้ยงดู กพ.
* ซบร. ยานพาหนะขั้นหน่วย
* ควบคุมดูแล การติดต่อส่งข่าว/ การส่ง สป.

ร้อย สร.สน.

มว.ส่งกลับ

ร้อย สร.

ผบ.มว.ส่งกลับ

ความรับผิดชอบ

* ช่วยเหลือในการรักษา กพ.ของหน่วย เมื่อได้รับการมอบหมาย
* รายงานสถานภาพของหน่วยต่อ ผบช.
* เมื่อต้องออกไปปฏิบัติงานนอกหน่วยจะต้องแจ้งให้ ศูนย์ข่าว ทราบ

การส่งกลับด้วยรถยนต์พยาบาล

อาจมีความจำเป็นทางยุทธวิธีที่ไม่สามารถใช้ รยพ.ได้ตลอดดังนั้น

* ต้องวางแผนการใช้ รถยนต์พยาบาล และ เปล ผสมผสานกัน
* ต้อง ลว.หา จุดเชื่อมต่อ ระหว่างเครื่องมือการส่งกลับทั้ง 2 ประเภท

การวางแผนใช้ พวกเปล

* ต้องคำนึงถึงขีดความสามารถในการบรรทุกไปกับ รยพ.
* การกินอยู่
* การนำ พวกเปล กลับที่ตั้งหน่วย

การบริการทางการแพทย์

ระดับกองพล

พัน.สร.พล.ร.

ร้อย สร.สน.

มว.ส่งกลับ

ร้อย สร.

ผบ.ตอนรถยนต์พยาบาล

* จัดตั้งแหล่งรวมรถ
* ควบคุมการใช้วิธีการส่งกลับของ รพย.
* กำหนดตำบลต่าง ๆ สำหรับ รยพ.
* เตรียมความพร้อมของพลขับ / รยพ. /สป./ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การปฏิบัติของตอนรถยนต์พยาบาล

* ทำการส่งกลับ ผป.จาก ที่พยาบาลต่าง ๆ และหน่วยแพทย์อื่น ในพื้นที่ของกองพล

- การรักษา ผป.ระหว่างทาง
- การเพิ่มเติม สป.สายแพทย์
- การสื่อสาร
- การขนส่ง/เคลื่อนย้าย กพ./สป.

ร้อย สร.สน.

มว.ส่งกลับ

ร้อย สร.

การตรวจภูมิประเทศ

* ผบ.มว.ส่งกลับ จะต้องสำรวจเส้นทางที่ใช้ได้ และที่คาดว่าจะสามารถใช้ได้ในอนาคต ทั้งนี้เพื่อ
  - ความคุ้นเคย
  - เตรียมเส้นทางสำรองไว้ในยามฉุกเฉิน
* ผบ.ตอนรถยนต์พยาบาล ควรร่วมไปด้วย

ร้อย สร.สน.

มว.ส่งกลับ

ร้อย สร.

แผนการใช้รถยนต์พยาบาล

* ผบ.มว.ส่งกลับ จัดทำแผนการใช้รถยนต์ พยาบาล
* เสนอแผน ฯ ต่อ ผบ.ร้อย.พิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปโดยสอดคล้องกับภารกิจของหน่วย ที่ได้รับมอบจากหน่วยเหนือ

ร้อย สร.สน.

มว.ส่งกลับ

ร้อย สร.

แผนการใช้รถยนต์พยาบาล

* เส้นทางหลัก / เส้นทางรอง ที่ตั้งสถานี รยพ. /ตำบลต่าง ๆ
* การจัด รยพ. ประจำสถานี รยพ. และที่จะให้สนับสนุน กรม ร.
* การจัด สป.ประจำ รยพ. และ การ ซบร.
* การจัดสวัสดิการให้ กพ. (พัก/เลี้ยงดู)

ร้อย สร.สน.

มว.ส่งกลับ

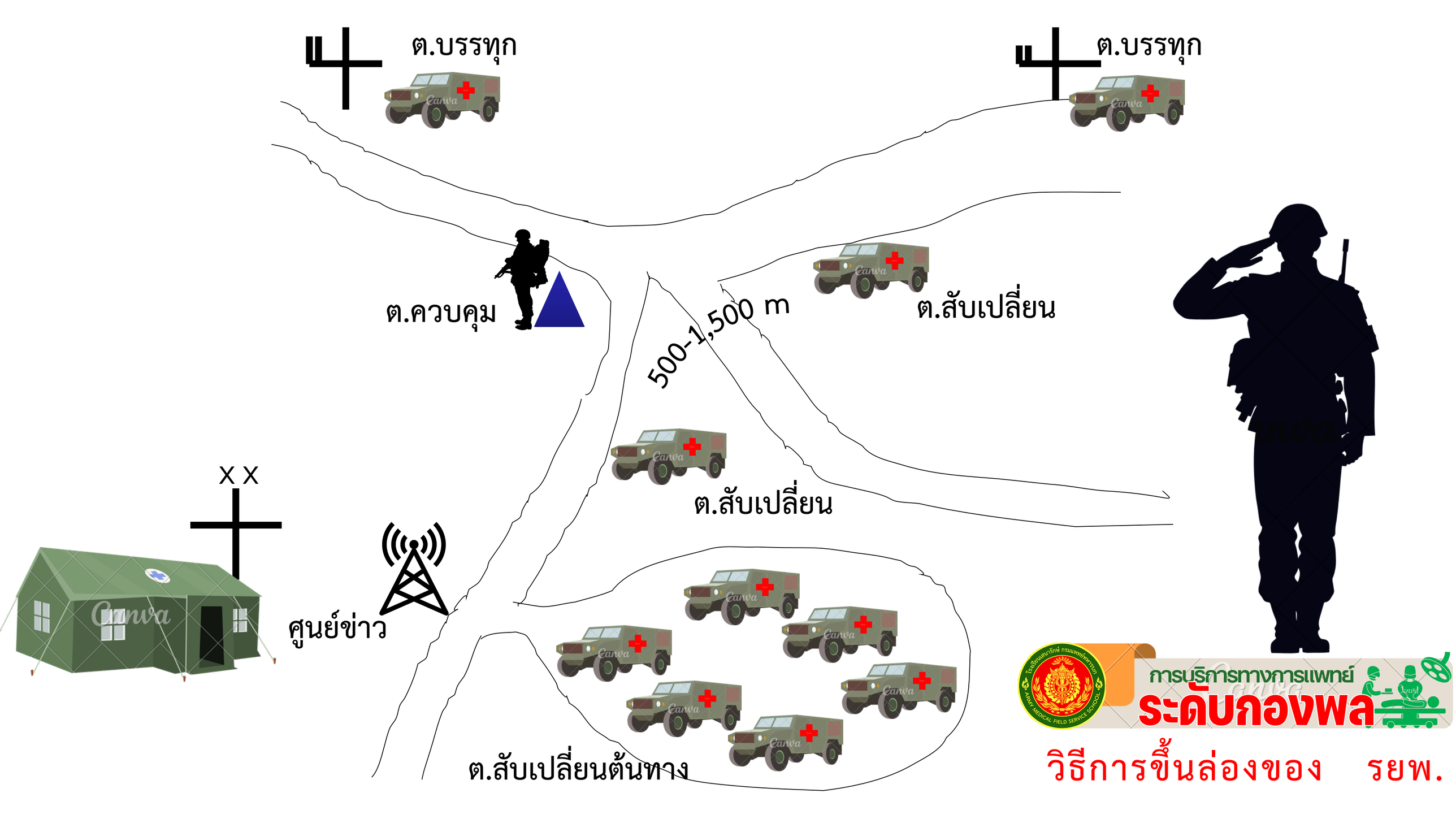
ร้อย สร.

ข้อพิจารณาเลือกเส้นทาง รยพ.

* เส้นที่มีอยู่ และใช้ได้
* ลักษณะสภาพของถนน
* ความหนาแน่นของการจราจร
* ระยะทางเมื่อเทียบกับเส้นทางอื่น
* ระยะห่างจากเป้าหมายของข้าศึก
* การป้องกันการตรวจการณ์/การยิง
* การกำบัง/ซ่อนพราง

วิธีการใช้รถยนต์พยาบาล

1. วิธีการขึ้นล่องของ รยพ. (THE AMBULANCE SHUTTLE)
2. วิธีการแทรกซึมของ รยพ. (THE AMBULANCE INFILTRATION)
3. วิธีการร้องขอการส่งกลับ (ON CALL EVACUATION)


ต.บรรทุก
ต.บรรทุก
ต.ควบคุม
500-1,500 m
ต.สับเปลี่ยน
ต.สับเปลี่ยน
X X
ศูนย์ข่าว
ต.สับเปลี่ยนต้นทาง
การบริการทางการแพทย์
ระดับกองพล
วิธีการขึ้นล่องของ รยพ.

ร้อย สร.สน.

วิธีการใช้รถยนต์พยาบาล

ร้อย สร.

วิธีการขึ้นล่องของ รยพ.

* เพื่อให้มี รยพ. ว่างพร้อมที่ ต.บรรทุก
* ลดอันตรายจากกระสุนแต่ละนัดของ ขศ.
* ป้องกันการคับคั่งของ รยพ.
* ป้องกันการติดขัดของการจราจร
* สามารถควบคุมการจราจรได้ดี

ร้อย สร.สน.

วิธีการใช้รถยนต์พยาบาล

ร้อย สร.

ข้อพิจารณาในการใช้วิธีขึ้นล่อง

* เมื่อ ขศ.ครองความเป็นเจ้าอากาศ หรือ ได้เปรียบในการตรวจการณ์ทางพื้นดิน
* จำนวนผู้ป่วยเจ็บใน ที่พยาบาลต่าง ๆ มีมาก
* มีจำนวนรถยนต์พยาบาลเพียงพอ

ร้อย สร.สน.

วิธีการใช้รถยนต์พยาบาล

ร้อย สร.

ข้อจำกัดในการใช้วิธีขึ้นล่อง

* ความปลอดภัยของ รยพ. ที่ ต. สับเปลี่ยน
* การหลงทางของพลขับ ถ้ามี ต.สับเปลี่ยน มากกว่า 1 แห่ง
* การขาดการติดต่อสื่อสาร
* การเลี้ยงดู กพ. ที่ประจำ ต.สับเปลี่ยน

ร้อย สร.สน.

วิธีการใช้รถยนต์พยาบาล

ร้อย สร.

วิธีการแทรกซึมของ รยพ.

* รยพ. ค่อย ๆ แยกย้ายไปรับ ผป.
* มีผลดีต่อการกระจาย รพย.
* ต. บรรทุก มีมากกว่า 1 แห่ง
* พลขับต้องรู้จักเส้นทางดี
* อาจตั้ง ต.ควบคุม/ไม่ตั้ง ต.สับเปลี่ยน

ต.บรรทุก

ต.บรรทุก

ต.ควบคุม

XX

ศูนย์ข่าว

ต.สับเปลี่ยนต้นทาง

การบริการทางการแพทย์
ระดับกองพล

วิธีการแทรกซึมของ รยพ.

ร้อย สร.สน.

วิธีการใช้รถยนต์พยาบาล

ร้อย สร.

วิธีการแทรกซึมของ รยพ.

ข้อดี

- ลดปัญหาด้านธุรการ / เพิ่มความปลอดภัย

ข้อเสีย

- ผป.คับคั่ง ณ ที่ปฐมพยาบาลต่าง ๆ
- ขาดความต่อเนื่องในการส่งกลับ

ร้อย สร.สน.

วิธีการใช้รถยนต์พยาบาล

ร้อย สร.

วิธีร้องขอการส่งกลับ (ON CALL EVACUATION)

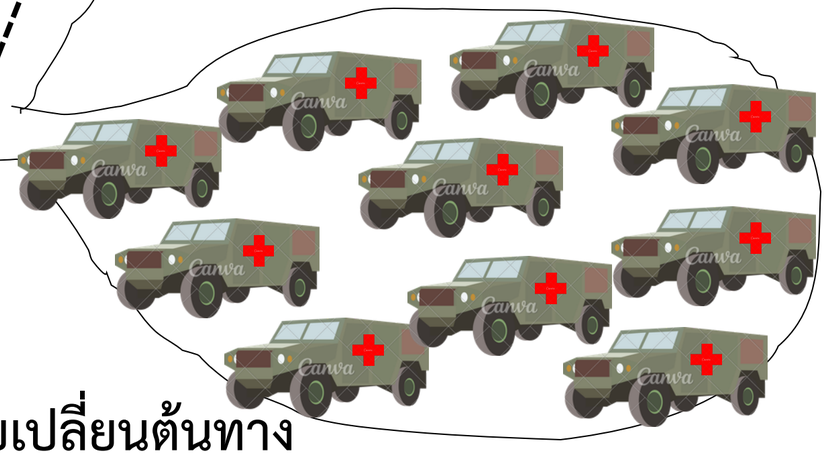
* รยพ. จะถูกส่งออกไปรับ ผป. เมื่อได้รับการร้องขอ
* มักใช้เมื่อเกิด ผป. ณ ที่ปฐมพยาบาล เป็นครั้งคราว
* เป็นวิธีที่ใช้ในการส่งกลับ ผป. ในพื้นที่ข้างหน้ามากกว่าวิธีอื่น

ต.บรรทุก

ต.บรรทุก

XX

ศูนย์ข่าว



ต.สับเปลี่ยนต้นทาง

การบริการทางการแพทย์

ระดับกองพล

วิธีร้องขอการส่งกลับ

ร้อย สร.สน.

วิธีการใช้รถยนต์พยาบาล

ร้อย สร.

การควบคุมรถยนต์พยาบาล

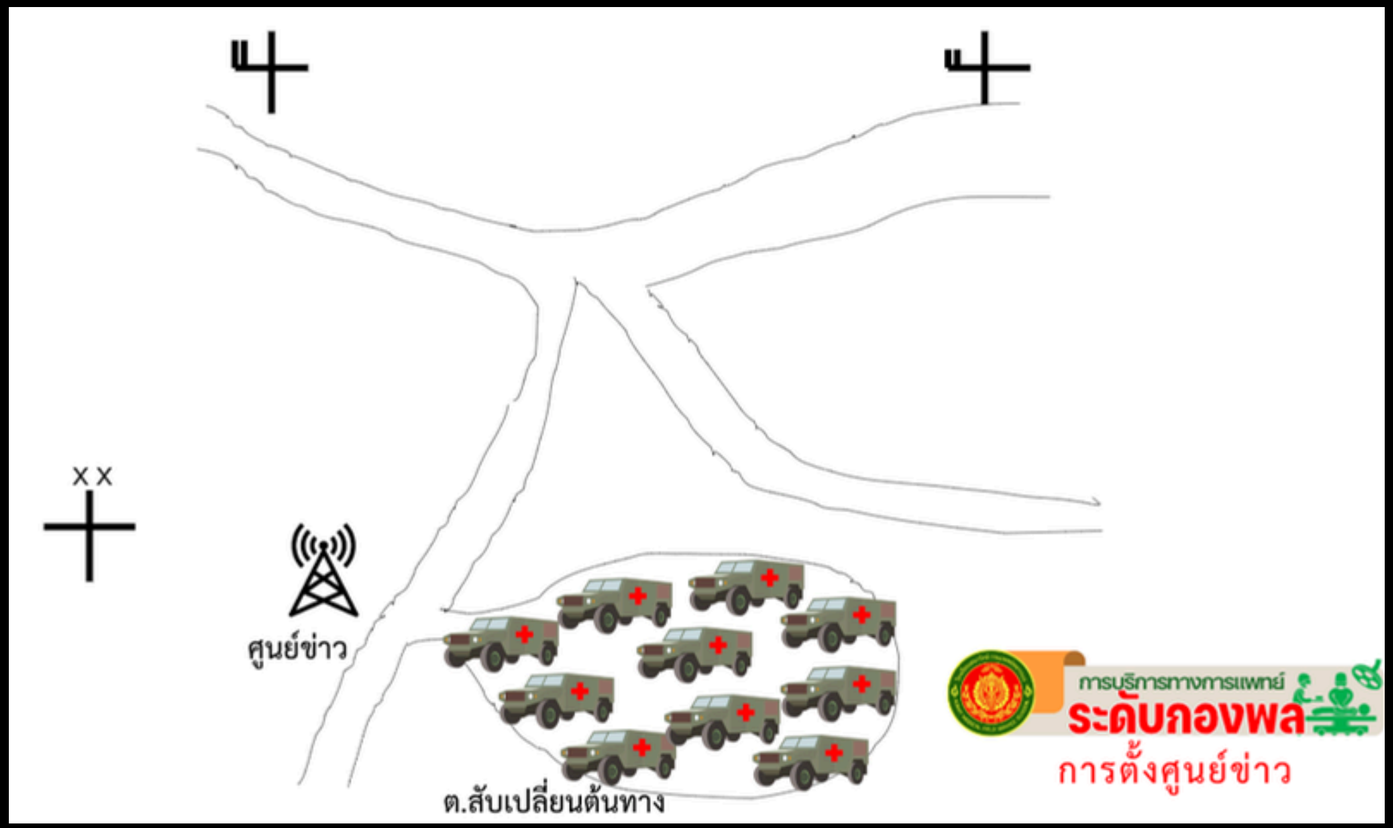
* ร้อย.สร.สน./ร้อย.สร. จัดตั้งสถานี รยพ.
* ผบ.ร้อย.บก. ควบคุม/รับผิดชอบการ ซบร.
* มว.ส่งกลับ ไม่จัดตั้งสถานี ซบร.
* ต.สับเปลี่ยนต้นทาง เป็น ต.ควบคุม รยพ. ที่ดีที่สุด

ร้อย สร.สน.

วิธีการใช้รถยนต์พยาบาล

ร้อย สร.

ศูนย์ข่าว



* ควรจัดตั้งอยู่ข้างเส้นทาง รยพ.
* บันทึก/รับ-ส่งข่าวสาร/ สป.ต่าง ๆ แล้วแจ้งให้ ทก.ร้อย.ทราบ ดำเนินการต่อไป
* ประสานตรวจสอบ รยพ. ว่าได้นำข่าวสาร/สป. ไปสนับสนุนหน่วยต่าง ๆ ถูกต้องหรือไม่ /ถ้าไม่ถูกต้องก็แจ้งให้ถ่ายโอนให้คันอื่น

ร้อย สร.สน.

วิธีการใช้รถยนต์พยาบาล

ร้อย สร.

บันทึกที่จัดทำ ณ ศูนย์ข่าว

ความมุ่งหมาย

* ทราบการใช้งาน รยพ. ของหน่วยตลอดเวลา
* ทราบจำนวน ผป. ที่ส่งกลับ

ร้อย สร.สน.

วิธีการใช้รถยนต์พยาบาล

ร้อย สร.

บันทึกที่จัดทำ ณ ศูนย์ข่าว

รายการที่ลงในบันทึก

ลำดับ	หมายเลขรถ	ยศ ชื่อ		เวลา		จำนวน ผป.	
		พลขับ	ส.พยบ.	ออก	เข้า	นั่ง	นอน
1	กงจักร 1234	ส.อ.มา ฯ	ส.อ. อ่วม ฯ	1000	1310	2	2

ร้อย สร.สน.

วิธีการใช้รถยนต์พยาบาล

ร้อย สร.

แผนและคำสั่งในการใช้ รยพ.

แผน

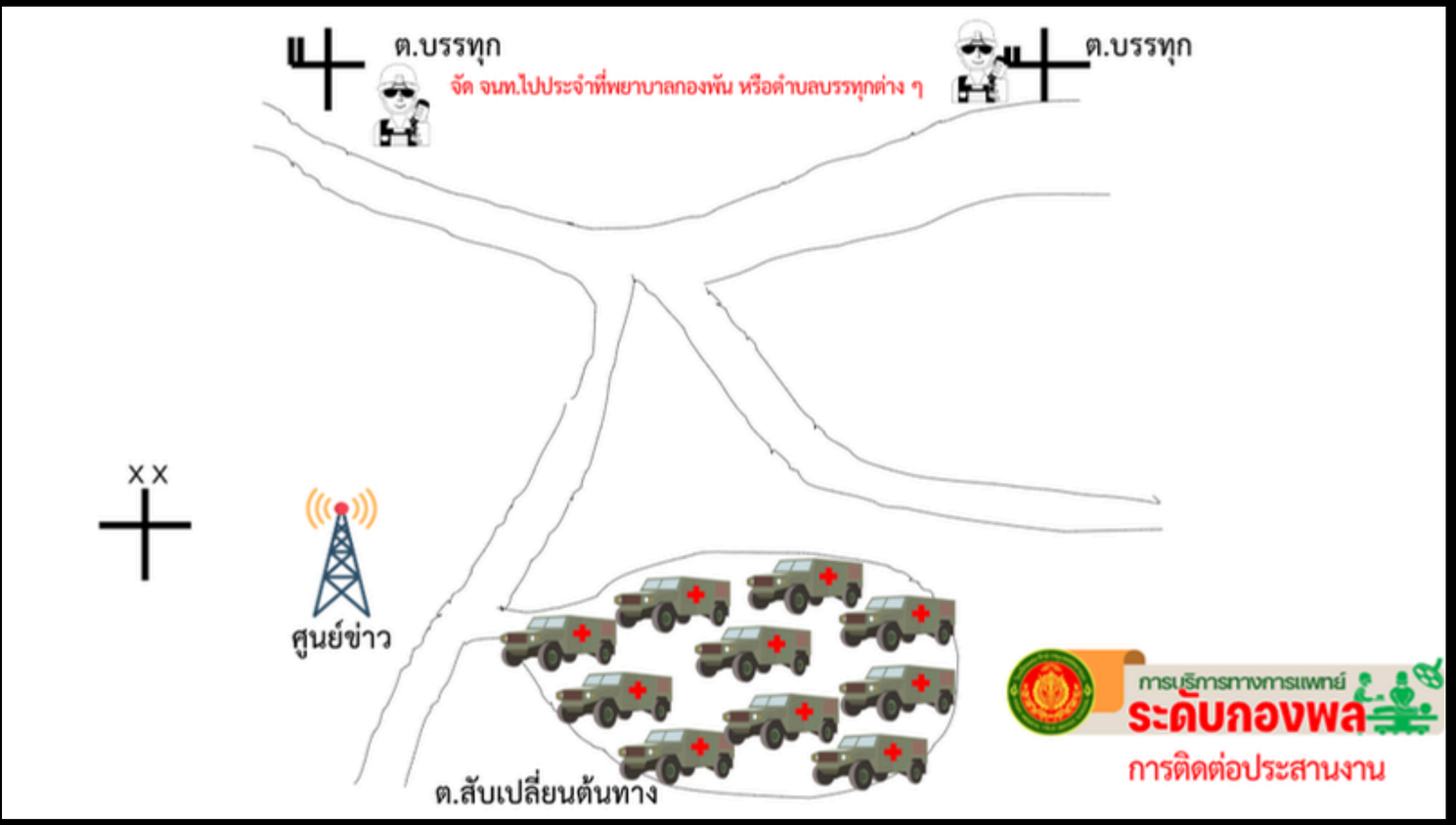
ต้องมีแผนสำรองในการใช้เส้นทาง

- สำรวจเส้นทางในพื้นที่
- ปฏิบัติได้จริง / มีการเตรียมการ

คำสั่ง

มักกระทำด้วยวาจา / คำสั่งเป็นส่วน ๆ

การติดต่อประสานงาน



* จัด จนท.ไปประจำ ที่พยาบาลกองพัน หรือตำบลบรรทุกต่าง ๆ

- กำกับดูแลการปฏิบัติในการขึ้นล่อง ของรถยนต์พยาบาล (ไม่ใช่ขนย้าย ผป.)
- แจ้งสถานการณ์ให้ ผบ.มว. ทราบ
- ช่วยกำกับดูแลการส่งข่าวสาร/แลกเปลี่ยน สป.ต่าง ๆ

ร้อย สร.สน.

การดูแล ผป.ระหว่างทาง

ร้อย สร.

การป้องกัน รยพ. / ผป.

* การซ่อนพราง (ข้อพึงระลึก การวางกำลังหน่วย พ. ทำให้ทราบถึงการวางกำลังของหน่วยทางยุทธวิธี)
* การกำบัง
* การกระจายกำลัง
* การเคลื่อนที่

การดูแล ผป.ระหว่างทาง

การป้องกัน รยพ. / ผป.

เครื่องหมายชี้ทาง

เพื่อป้องกันการสับสนของพลขับ ตามเส้นทาง รยพ. ควรจะทำเครื่องหมายชี้ทางจุดที่สำคัญ ๆ ไว้ด้วย

การซ่อมถนน/สะพาน

ถึงแม้ไม่ใช้หน้าที่ แต่ก็ควรมีเครื่องมือเครื่องใช้ประจำรถไว้ให้พร้อมด้วย

ร้อย สร.สน.

การดูแล ผป.ระหว่างทาง

ร้อย สร.

ข้อพิจารณาในการวางแผนการส่งกลับ

* การดูแล ผป.ระหว่างทางที่พอเพียง
* วิธีการส่งกลับที่รวดเร็วที่สุด
* เส้นทางส่งกลับที่สั้นที่สุด
* การให้ ผป.มีความสะดวกสบายที่สุด
* ต้องมีความปลอดภัย

สรุปการปฏิบัติในการส่งกลับ

ความรับผิดชอบ

- หลังจากการบรรทุก ผป.ขึ้น รยพ. แล้วจะเป็นหน้าที่ของที่รักษาพยาบาลกองทัพ

การดูแล ผป.ระหว่างทาง

- ควรจัดให้มีตลอดเส้นทางการส่งกลับทุกระดับ

สรุปการปฏิบัติในการส่งกลับ

* การส่งกลับ ผป.

- การคับคั่งของ ผป.ด้านศัลยกรรม ณ ที่รักษาพยาบาลของกองทัพ อาจจำเป็นต้องส่งกลับ ผป. ไปยัง ที่รักษาพยาบาลกองทัพ มากกว่า 1 แห่ง

* การแลกเปลี่ยน สป. ต้องกระทำทุกขั้นตอน

สรุปการปฏิบัติในการส่งกลับ

* การติดต่อสื่อสาร จำเป็นอย่างยิ่งในการควบคุมการส่งกลับ

* การทำเครื่องหมายยานพาหนะ

- เครื่องหมายกาชาด ต้องเป็นไปตามนโยบายของ ผบช. และต้องไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อส่วนรวม

ร้อย สร.สน.

การปฏิบัติของ ตอนเปล

ร้อย สร.

หน้าที่

* ส่งกลับ ผป.จาก ที่พยาบาลกองพัน กรณี รยพ. ไม่สามารถดำเนินการได้

- ผบ.ตอนเปล ควรประสานกับ ผบ.ตอน รยพ. หาจุดเชื่อมต่อ
- เปล เป็นเครื่องมือที่ดีโดยเฉพาะการรบในพื้นที่ป่าภูเขา

ร้อย สร.สน.

การปฏิบัติของ ตอนเปล

ร้อย สร.

หน้าที่

ถ้าจำเป็นอย่างยิ่งยวด อาจจัดไปสมทบ **ตอนส่งกลับ** ของ มว.สร.พัน.ร./กรม ร. ที่สนับสนุนโดยตรงได้

พวกเปล (1 พวก เปลจะมี 4 นาย)

- ทำการลำเลียง ผป. / ส่งกำลัง สป.
- นำสาร / ปัจจุบันพยาบาล ผป. ระหว่างทาง

คนฉลาด...ชอบแกล้งโง่

คนโง่...ชอบเสแสร้งว่าฉลาด

ส่วน “นักปราชญ์”

เรียนรู้ที่จะ “ฉลาด” และ...

เรียนรู้ที่จะ “โง่”

วัฒนาอาสาม

คุยกับท่าน ว.วชิรเมธี